CGU
Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Secretaria de Vigilância em Saúde e Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

Exercícios 2020-2025

7 de novembro de 2025

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: **Ministério da Saúde (36000)**
Unidades Auditadas: **Secretaria de Vigilância em Saúde e Secretaria Executiva**
Município/UF: **Brasília/DF**
Relatório de Avaliação: **1379967**

Missão
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Trata-se de Auditoria de Avaliação da governança nas emergências em saúde pública (ESP) no âmbito do Ministério da Saúde (MS) e do SUS.

A auditoria teve como objeto a institucionalização da resposta às ESP, segundo paradigma proposto pela OMS e à semelhança da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), além de princípios e boas práticas de governança.

Nesse sentido, foram avaliados: Institucionalização enquanto política pública; Participação dos entes federados, especialistas e social na política e nas decisões; Processo decisório; Coordenação e cooperação; Visão de futuro, especialmente quanto à redução de vulnerabilidades e planejamento geral e de contingências; além de Comunicação e informação.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Emergências em saúde pública e desastres ambientais são eventos correlatos e impactam profundamente a saúde das pessoas e de múltiplos setores. É necessário reduzir os riscos e impactos desses eventos de frequência crescente. Pretende-se contribuir para o aperfeiçoamento da governança na resposta às ESP e a melhoria dos resultados em saúde, além de evitar a reincidência de falhas na resposta à pandemia de Covid-19.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES?

A avaliação evidencia lacunas e fragilidades na governança da resposta governamental às Emergências em Saúde Pública, sob a perspectiva da institucionalização. A falta de uma política pública de Estado específica para resposta às ESP é considerada causa mediata ou imediata dos principais problemas constatados na resposta à pandemia de Covid-19 e um risco para a reincidência em futuras ESP.

Os aspectos que carecem de institucionalização são principalmente os do processo decisório, com a participação das partes interessadas, mecanismos de liderança e de coordenação intersetorial e intergovernamental, instrumentos de comunicação e de transparência, elaboração de planos de contingências, bem como o processo de lições aprendidas.

Assim, torna-se necessário uma sólida institucionalização de normas, notadamente uma política de estado específica, prevendo a atuação dos diversos órgãos, instituições e esferas de governo envolvidos, para evitar mudanças prejudiciais intempestivas e/ou frequentes, prejudicando o desempenho de funções técnico-especializadas (especialmente no âmbito de atuação do COE).

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AD	Administração Direta
ADIn	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
CCOP	Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19
CEPEDES	Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde
CGU	Controladoria-Geral da União
CIB	Comissão Intergestores Bipartite
CIEVS	Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
CIG-MS	Comitê Interno de Governança do Ministério da Saúde
CIT	Comissão Intergestora Tripartite
CME	Comitê de Monitoramento de Eventos
CNS	Conselho Nacional de Saúde
COE	Centro de Operações de Emergências em Saúde
COE Covid-19	Centro de Operações de Emergências para a Covid-19
COE-nCoV	Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
CONASS	Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CONASEMS	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
CONPDEC	Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
CTA-ESP	Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública
CTAI Covid-19	Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19
DATASUS	Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde
DEMAS	Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde
DEMSP	Departamento de Emergências em Saúde Pública
DEDT	Departamento de Doenças Transmissíveis

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública

ESP Emergência em Saúde Pública

Espin Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional

ESPII Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional

FN-SUS Força Nacional do Sistema Único de Saúde

GEI-ESPII Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional

GC-GSI Gabinete de Crise do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

GM Gabinete Ministerial

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

LOA Lei Orçamentária Anual (LOA)

MS Ministério da Saúde

OMS Organização Mundial da Saúde Plano Plurianual

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde

PAS Programação Anual de Saúde

PEI Planejamento Estratégico Institucional

PNI Programa Nacional de Imunizações

PNS Plano Nacional de Saúde

PPA Plano Plurianual

PNPDEC Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

PNVS Política Nacional de Vigilância em Saúde

PRESP Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública (PRESP)

Rede VIGIAR-SUS Rede de Vigilância, Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública do SUS

RIPSA Rede Interagencial de Informações para a Saúde

RSI Regulamento Sanitário Internacional

SAES Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

SAPS Secretaria de Atenção Primária à Saúde

SAS Secretaria de Atenção à Saúde

SCTIE Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde

SE	Secretaria Executiva
SGTES	Secretária de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -; -
SESAI	Secretaria Especial de Saúde Indígena
SVSA	Secretaria de Vigilância em Saúde -;
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEIDIGI	Secretaria de Informação e Saúde Digital
SES	Secretaria de Estado de Saúde
SFC	Secretaria Federal de Controle Interno
SI-PNI	Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização
SIES	Sistema de Informação de Insumos Estratégicos
SIME	Sistema Integrado de Monitoramento de Eventos
SINPDEC	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
STF	Supremo Tribunal Federal
SUS	Sistema Único de Saúde
TCU	Tribunal de Contas da União

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 9

Contextualização da Avaliação de Institucionalização da Resposta às ESP 10

Referencial da OMS para gestão baseada em riscos das Emergências em Saúde Pública e de Desastres Ambientais. 11

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 12

As Instituições de Resposta às ESP no Brasil. 13

A experiência da pandemia de Covid-19 13

Referenciais para Avaliação de Governança do TCU 14

RESULTADOS DOS EXAMES 15

1. Ausência de política pública de Estado para resposta às emergências em saúde pública. 15

2. Necessidade de aperfeiçoamento da institucionalização do processo decisório nas ESP. 21

3. Necessidade de instituir um conselho deliberativo plural no âmbito de uma política de Estado de resposta às ESP. 24

4. A atuação do Centro de Operações de Emergências (COE) está sujeita a limitações para o desempenho na resposta às ESP. 27

5. Fragilidade da institucionalização de mecanismos de liderança pelo MS prejudicou a coordenação no enfrentamento de emergência em saúde pública. 30

6. Fragilidade dos mecanismos institucionalizados para a coordenação da comunicação entre os diferentes níveis de governo e com a população. 35

7. Desafios na governança e interoperabilidade dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em Saúde. 40

8. O Planejamento de contingências apresenta limitações e carece de institucionalização. 43

9. O planejamento do MS passou a contemplar indicadores e metas que visam à promoção de resiliência frente às ESP. 48

10. Dependência tecnológica a insumos estratégicos: necessidade de institucionalização integrada em uma política de Estado no enfrentamento às ESP. 51

11. Fragilidade da institucionalização do Processo de lições aprendidas. 55

RECOMENDAÇÕES 59

CONCLUSÃO 61

ANEXOS 64

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 64

II – As Instituições de Resposta às ESP no Brasil. 71

III – Problemas relevantes constatados durante a pandemia de Covid 19 sob a perspectiva da governança da resposta às Espin. 74

IV - Aspectos que demandam ação coordenada durante uma Espin – Resultados na pandemia de Covid 19. 76

V – Referências 78

INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Projeto de Auditoria nº 1379967 examinou-se a governança no enfrentamento às Emergências em Saúde Pública (ESP), junto ao Ministério da Saúde (MS) e ao SUS. A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVSA) do MS é responsável pela coordenação das ações de vigilância em saúde nas ESP, segundo a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), aprovada pela Resolução nº 588/2018, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual é considerada uma "política pública de Estado e função essencial do SUS".

A institucionalização da resposta às ESP foi o único componente de governança selecionado para avaliação, por ser considerado elemento primordial em políticas públicas e que condiciona os demais componentes de governança, a exemplo de coordenação, participação, gestão de riscos e outros. Foi avaliado se os seguintes elementos estão institucionalizados no Brasil e em que medida: a) Institucionalização da resposta às ESP enquanto política pública de Estado; b) Participação dos entes federados, especialistas e sociedade civil na política e nas decisões; c) Processo decisório; d) Coordenação e cooperação; e) Visão de futuro, especialmente quanto à redução de vulnerabilidades, promoção de capacidades e resiliência e planos; e f) Comunicação e informação.

A escolha do objeto da presente auditoria decorre da importância estratégica, a relevância, a materialidade e a criticidade das ESP, além da oportunidade, que podem ser aferidas a partir da experiência recente do Brasil com a pandemia de Covid-19.

Considerando o exposto, os objetivos da auditoria visam o aperfeiçoamento da governança da resposta governamental às ESP no Brasil e a melhoria dos resultados em saúde nesses eventos, além de propor aperfeiçoamento nas práticas de governança e meios para evitar que no futuro haja a repetição de falhas constatadas na resposta à pandemia de Covid-19.

Para os fins propostos, foram formuladas as seguintes questões de Auditoria, consignadas na Matriz de Planejamento deste trabalho:

1. Em que medida o enfrentamento de emergências em saúde pública de importância nacional no âmbito do MS e no país foi institucionalizado formal e adequadamente?
2. A visão de longo prazo para o enfrentamento de Emergências em Saúde Pública (ESP) é respaldada por atos normativos, planejamento estratégico e/ou projetos, notadamente quanto à redução de vulnerabilidades e ao desenvolvimento de resiliência?
3. A institucionalização do enfrentamento de emergências em saúde pública promove a articulação efetiva entre o MS e a União com as demais esferas de governo e tendo em conta as redes transorganizacionais e relações de interdependência?
4. A institucionalização dos arranjos para promoção da *accountability* no âmbito do MS e da União preveem mecanismos e instrumentos adequados de comunicação e de transparência das ações relativas ao enfrentamento das ESP?

A metodologia empregada compreende a Análise documental, abrangendo normas, manuais, planos, relatórios, notas técnicas, artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros,

sítios na internet, respostas às solicitações de auditoria e acórdãos do TCU, complementada por consultas a bases de dados e indagação oral e escrita. Embora o período analisado compreenda principalmente os anos entre 2020 e 2024, a análise não se limita a estes, já que há determinados documentos produzidos antes do ano de início da pandemia de Covid-19, como é o caso da análise comparativa de normas.

Emprega-se, em particular, a "meta-avaliação", que é uma avaliação ou revisão de avaliações realizadas por outras entidades, segundo as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (INSTITUTO RUI BARBOSA, 2020). Em relação aos riscos observados a partir das diferentes fontes de informação, a NBC TA – Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração informa que segurança maior geralmente é obtida de evidências consistentes de fontes ou de natureza diferentes do que evidências consideradas individualmente.

Adicionalmente, dentre os testes executados durante as ações de controle, destacam-se a análise de informações prestadas pelas áreas técnicas do MS, a busca ativa de informações existentes no sítio oficial do MS e de outras instituições que atuam no tema, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Fiocruz, as opiniões ou testemunhos de diferentes partes envolvidas, especialmente Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), além de sintetizar as avaliações sobre a matéria, realizadas principalmente pelos órgãos de controle (CGU, TCU, STF etc.).

Ressalta-se que a presente avaliação adotou como critério de auditoria principalmente as boas práticas difundidas pela CGU (Manuais "ex ante" e "ex post") e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio de seus Referenciais de avaliação de Governança; Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal; Lei 8080/1990 – Lei Orgânica do SUS; Lei nº 8.142/1990 – que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) – Resolução CNS nº 588/2018 e em dois *benchmarking* (boa prática), sendo o primeiro A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) - Lei nº 12.608, de 10.04.2012 e o segundo um referencial da Organização Mundial de Saúde intitulado "Emergency Disaster Risk Management Framework (EDRM)" (WHO, 2019).

No trabalho foram observadas as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Contextualização da Avaliação de Institucionalização da Resposta às ESP

A resposta às Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) deve estar alinhada aos princípios e capacidades estabelecidos pelo Regulamento Sanitário Internacional (RSI – 2005), aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 395, de 9.07.2009. Embora o RSI trate formalmente das Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), suas diretrizes orientam a estruturação das respostas nacionais, exigindo preparo, coordenação e cooperação interfederativa para garantir a prontidão do país diante de eventos de saúde pública de qualquer magnitude.

Além disso, espera-se que os desastres ambientais e emergências em saúde pública correlatas se tornem mais frequentes e mais graves. Logo, há de se considerar o risco crescente de novas ESP. Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019):

> As mudanças climáticas, a urbanização não planejada, o crescimento e o deslocamento populacionais, a resistência antimicrobiana e a fragilidade dos Estados contribuem para o aumento da frequência, da gravidade e dos impactos de muitos tipos de eventos danosos que podem levar a emergências e catástrofes, sem uma gestão eficaz dos riscos.

Desastres ambientais e emergências em saúde pública são eventos estreitamente relacionados, inclusive a OMS propõe uma abordagem para gestão integrada de ambos, como será visto. Nesse sentido, mais de 200 periódicos internacionais de saúde pública, medicina e correlatos subscreveram um editorial publicado no final de 2023 (BMJ, 2023), no qual entidades e especialistas em todo o mundo consideram que as mudanças climáticas e a crise ambiental com perda de biodiversidade já são tão severas que devem ser tratadas como uma emergência de saúde global e indivisível (JAMA, 2023), para se preservar a saúde pública e evitar uma catástrofe. Por considerarem que as três condições prévias para declaração de Espin já estavam presentes[1], as referidas entidades apelaram à OMS para que fizesse essa declaração antes ou durante a 77ª Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreria em maio de 2024.

Os impactos da pandemia de covid-19 se estenderam sobre diversos setores nacionais, dentre os quais: social, educacional, cultural, político, econômico, comercial, empresarial, industrial e outros. Há diversos artigos publicados sobre os efeitos para a saúde pública pós-pandemia.

Referencial da OMS para gestão baseada em riscos das Emergências em Saúde Pública e de Desastres Ambientais.

Emergências em saúde pública e desastres ambientais são eventos que impactam profundamente a saúde das pessoas, põem em risco a cobertura universal de saúde e as agendas de desenvolvimento dos países, afetam desproporcionalmente os mais vulneráveis e podem atrasar o desenvolvimento por décadas, por isso reduzir esses riscos e impactos deve ser uma das prioridades mais prementes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na publicação referenciada anteriormente, a OMS (WHO, 2019) propõe uma abordagem de gestão de emergências em saúde pública e de desastres ambientais integrada e baseada em riscos, com ênfase em prevenção, preparação, resposta e recuperação, além de prontidão, integrada em políticas e estratégias relevantes e apoiadas por legislação apropriada (grifos nossos).

Em inglês, a expressão para o novo paradigma da OMS é *Emergency Disaster Risk Management Framework* (EDRM).

[1] As três condições prévias para a OMS declarar uma situação como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional são: (1) ser grave, súbita, invulgar ou inesperada; (2) ter implicações para a saúde pública para além da fronteira nacional do Estado afetado; e (3) pode exigir ação internacional imediata.

Na tabela a seguir se apresenta o que muda com essa nova abordagem proposta, comparativamente às abordagens tradicionais:

Quadro 1 - Sumário da mudança de abordagem por meio da ERDM.

DE	**PARA**
Baseada em eventos	Baseada em riscos
Reativa	Proativa
Uma única ameaça	Todas as ameaças
Foco na ameaça	Foco na vulnerabilidade e capacidade
Agência única	Toda a sociedade
Responsabilidades separadas	Responsabilidades compartilhadas dos sistemas de saúde
Foco na resposta	Gestão de riscos
Planejamento para as comunidades	Planejamento com as comunidades

Fonte: adaptada da publicação da OMS. *World Health Organization*. *Health Emergency and Disaster Risk Management Framework*.

São reproduzidos, abaixo, trechos da publicação da Organização mundial de Saúde (OMS) já referida, que constituem referência para compreensão dos temas abordados no relatório e argumento em favor da institucionalização formal de uma política pública de Estado específica para o enfrentamento das ESP:

> POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E LEGISLAÇÃO
> As considerações de EDRM na saúde devem ser integradas em políticas e estratégias relevantes, apoiadas por legislação apropriada. Devem ser incluídos nas políticas, estratégias e planos nacionais de saúde, estar alinhados com o planejamento nacional e os ciclos orçamentários e ser integrados numa vasta gama de programas de saúde nacionais e subnacionais.
>
> Uma política ou estratégia nacional sobre EDRM de Saúde deve delinear os papéis e responsabilidades de todas as partes interessadas públicas, privadas e da sociedade civil, em todos os componentes do EDRM de Saúde para todos os perigos, e incluir os responsáveis pelo planejamento e coordenação, RSI (2005), vigilância e alerta precoce, preparação e resposta a emergências, recuperação, hospitais e serviços de saúde e relacionados.

Assim, não só a institucionalização adequada é preconizada nos referenciais do TCU para avaliação da governança pública, mas figura na abordagem proposta pela OMS, segundo a qual os elementos da abordagem de gestão de emergências em saúde pública e de desastres ambientais, integrada e baseada em riscos, devem ser integrados em políticas e estratégias relevantes, apoiadas por legislação apropriada.

Considerando o exposto, conclui-se que o Referencial da OMS constitui a um só tempo referência para compreensão e análise dos temas avaliados e critério para a avaliação da governança na resposta às ESP no país.

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)

Depois dos desastres ambientais que ocorreram nos anos de 2010 e 2011 nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco, o Brasil instituiu a PNPDEC, mediante a Lei nº 12.608/2012,

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC).

No tocante aos temas correlatos às respostas às emergências nacionais, considera-se aqui que a PNPDEC é a política pública de Estado que mais se aproxima dos critérios propostos para o presente trabalho, pois, no âmbito específico de resposta aos desastres ambientais – que são correlatos às ESP, a referida política está formalmente instituída mediante Lei e possui diversos atributos desejáveis para que a institucionalização da resposta às calamidades públicas em geral seja considerada adequada.

Pelas razões expostas, a PNPDEC será adotada enquanto paradigma para nortear as análises e fornece critérios para a avaliação da institucionalização da resposta às emergências em saúde pública no Brasil, os quais serão discutidos em detalhes nos pontos em que for aplicável.

As Instituições de Resposta às ESP no Brasil.

No anexo II estão descritas as principais instituições de resposta às ESP no Brasil, quanto aos seus aspectos básicos. Assim é possível ter uma visão geral da situação, desde antes da pandemia de Covid-19, até os dias atuais. Depois, no Anexo III, aquelas que foram instituídas para o desempenho de funções no contexto da pandemia de Covid-19.

No país, diversas instituições atuam ou atuaram na resposta às emergências em saúde pública em geral e na resposta à pandemia de Covid-19, em particular. Ainda que algumas dessas instituições não existam mais, entende-se que apresentá-las é indispensável para a análise da institucionalização, dada a subsistência das causas de problemas ocorridos ou porque há o risco de recorrência.

A experiência da pandemia de Covid-19

Considerando os princípios e parâmetros selecionados para nortear as avaliações de governança em saúde, o aperfeiçoamento da governança deve ter em conta as falhas constatadas no enfrentamento das emergências, o desempenho observado e as lições aprendidas. Daí é possível identificar as potenciais causas de falhas (notadamente aquelas consideradas críticas ou até mesmo catastróficas, no contexto da pandemia de Covid-19) e do desempenho medido em termos dos resultados em saúde (efetividade), para promoção de melhorias e para evitar que problemas análogos se repitam no futuro, demandando que a avaliação vá além de aspectos meramente formais e de conformidade – que nem sempre correspondem ao que se pratica de fato.

O objetivo é analisar a institucionalização da resposta às ESP a partir da situação ocorrida e da situação atual, identificar as causas em potencial correlatas à governança e então recomendar, com o intuito de evitar que no futuro ocorram erros relevantes iguais ou semelhantes àqueles constatados na resposta governamental à pandemia em comento.

Assim, todos os achados do presente Relatório trazem os seguintes tópicos:
a) Situação observada durante a pandemia de Covid 19; e

b) Situação atual.

Referenciais para Avaliação de Governança do TCU

Os referenciais para avaliação de governança do TCU abrangem três perspectivas de avaliação, quais sejam:
a) No âmbito de uma determinada organização ou setor intragovernamental (BRASIL, 2020b);
b) Entre os diferentes setores de um determinado governo (BRASIL, 2016) – que se refere à governança em Centro de Governo (CG), com o fim de apoiar o chefe do poder executivo, olhar a totalidade da ação governamental e assegurar coerência e coesão às diversas iniciativas propostas pelo governo eleito; e
c) Entre as diferentes esferas governamentais (BRASIL, 2014b) - que se refere à governança na implementação das políticas públicas, em âmbito nacional, mediante participação cooperativa e coordenada da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Especificamente para a avaliação da governança em Políticas Públicas (BRASIL, 2014b) o TCU propõe oito componentes dos quais foi selecionado para avaliação o primeiro da lista a seguir:

1) Institucionalização;
2) Planos e Objetivos;
3) Participação;
4) Capacidade Organizacional e Recursos;
5) Coordenação e Coerência;
6) Monitoramento e Avaliação;
7) Gestão de Riscos e Controle Interno; e
8) *Accountability*.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Ausência de política pública de Estado para resposta às emergências em saúde pública.

O presente Achado visa avaliar em que medida o enfrentamento de emergências em saúde pública de importância nacional no âmbito do MS e no país foi institucionalizado formal e adequadamente.

Conforme será visto, fatos constatados durante a resposta à pandemia de Covid-19 demonstram a prevalência no país de lacunas e falhas que limitam a resposta às ESP. Falhas da mesma natureza são mencionadas no texto da OMS – a exemplo da atuação reativa e não com ênfase em prevenção; falta de preparação e de prontidão; e lacunas e deficiências na coordenação nacional –, assim como a ausência das condições desejáveis para uma política nacional de resposta às ESP, com foco na gestão de riscos e resposta às emergências em saúde e desastres de forma integrada, alinhada aos princípios e boas práticas de governança.

Já foi dito que a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019) propõe uma abordagem de gestão de emergências em saúde pública e de desastres ambientais integrada e baseada em riscos. Para a gestão de desastres ambientais o Brasil já possui uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída mediante a Lei nº 12.608/2012, a qual possui diversos atributos adequados à abordagem de gestão de riscos de desastres proposta pela OMS, à semelhança do que se espera para a resposta às ESP.

Ressalte-se que uma política ou estratégia nacional sobre EDRM de Saúde deve delinear os papéis e responsabilidades de todas as partes interessadas públicas, privadas e da sociedade civil, em todos os componentes do EDRM de Saúde para todos os perigos, e incluir os responsáveis pelo planejamento e coordenação, RSI (2005), vigilância e alerta precoce, preparação e resposta a emergências, recuperação, hospitais e serviços de saúde e relacionados.

Segundo o TCU (BRASIL, 2014b), “Espera-se que uma política pública esteja jurídica e oficialmente formalizada, com o estabelecimento de normas, padrões e procedimentos que definam claramente as arenas decisórias, a divisão de competências e as atribuições dos atores envolvidos”. No tocante à promoção da capacidade de liderança, o referencial acrescenta: “[...] A alta rotatividade de líderes somada à ausência ou deficiência de regras de transição podem levar à descontinuidade na realização das atividades da liderança [...]”.

Considerando o exposto, dentre os critérios de adequação da situação analisada estão incluídos princípios e diretrizes alinhados com aqueles da política de governança da administração pública federal (Decreto nº 9.203/2017) e aqueles preconizados enquanto princípios, diretrizes e boas práticas nos referenciais de governança do TCU (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2020b), embora não necessariamente se limitem a esses.

1.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

No presente tópico serão detalhados fatos que caracterizam inobservância de princípios e boas práticas de governança na institucionalização da resposta às ESP no país, relacionados à falta de uma política pública de Estado específica para resposta. A ênfase recai sobre os aspectos mais relevantes, o que em geral estão relacionados ao desempenho das funções críticas de coordenação, articulação, integração e processo decisório estratégico na resposta às ESP.

A hipótese é de que, não obstante a preexistência de instituições técnicas-operacionais que atuavam de forma integrada desde antes da pandemia, dada a falta de uma política pública de Estado, as fragilidades e vulnerabilidades institucionais e a não aderência a princípios e boas práticas de governança, a resposta dessas foi prejudicada, com resultados em saúde insatisfatórios.

A pandemia de Covid-19 demonstrou a falta de uma política pública de Estado específica para resposta às emergências em saúde pública (ESP). Embora o Brasil já contasse com um conjunto de instituições e normas estruturadas antes da crise — como o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 395/2009, a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pela Resolução CNS nº 588/2018, a Declaração de Espin (Decreto nº 7.616/2011), o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE), os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e a rede VigiAR-SUS — a inexistência de um marco legal robusto prejudicou a coordenação nacional, a articulação interfederativa e a efetividade das medidas sanitárias, resultando em fragilidade institucional e vulnerabilidade a injunções político-governamentais.

Com a Covid-19, diversas instâncias foram criadas ou reativadas. O Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII), reinstituído pelo Decreto nº 10.211/2020, deveria articular medidas interministeriais, mas, segundo o TCU (Acórdão nº 1.967/2023), não desempenhou suas funções, que foram absorvidas pelo Comitê de Crise da Casa Civil. Este Comitê, criado pelo Decreto nº 10.277/2020 e ampliado pelo Decreto nº 10.404/2020, gerou sobreposição de competências com o GEI-ESPII e foi extinto em 2022.

No âmbito do Comitê, foi instituído o Centro de Coordenação de Operações (Decreto nº 10.289/2020), com atribuições de articular e monitorar ações, embora sem clareza sobre suas diferenças em relação ao COE do Ministério da Saúde. O MS, por sua vez, criou o Gabinete de Crise da Covid-19 (Portaria GM/MS nº 3.190/2020), incluindo representantes do Conass, Conasems e OPAS. Contudo, conforme o TCU, até outubro de 2020 sua estrutura não estava formalmente regulamentada.

Em 2021, foi instituída a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid), responsável por coordenar medidas nacionais e o Plano Nacional de Vacinação, mas também transitória, extinta em 2022. No mesmo ano, o Decreto nº 10.659/2021 criou o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia, com participação dos chefes dos três Poderes, que teve atuação restrita e breve. Mais recentemente, em 2023, foi criada a Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública (CTA-ESP), com ampla participação de especialistas e instituições, considerada pelo MS um passo para consolidar uma política nacional permanente. O papel de todas as instituições citadas está detalhado no Anexo II deste Relatório.

De forma geral, a experiência brasileira na pandemia evidenciou que, embora houvesse uma base normativa e institucional, a criação de múltiplos arranjos — frequentemente sobrepostos, pouco articulados e sem participação federativa robusta — fragilizou a governança. O TCU reiterou, em diversos acórdãos, a necessidade de institucionalizar de forma estável as funções de Centro de Governo e de COE, para garantir coerência e prontidão na resposta. Conass, Conasems, Fiocruz e OPAS reforçaram que a falta de coordenação federativa e intersetorial foi um dos maiores entraves no enfrentamento à crise sanitária.

Manifestações institucionais

O Conasems, em resposta à auditoria da CGU, destacou que atos normativos federais muitas vezes desconsideraram critérios técnicos e científicos, priorizando fatores econômicos, conforme apontado em estudos do CEPEDISA/USP. O Conselho defendeu a necessidade de revisão do arcabouço legal e regulatório para garantir clareza e eficácia.

O CEPEDES/Fiocruz, em relatório de 2020, concluiu que a falta de confiança no governo federal prejudicou a cooperação federativa, gerando respostas descoordenadas dos estados.

O STF, no julgamento da ADI 6.341/2020 (Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin), reconheceu a competência concorrente da União, Estados e Municípios (CF, arts. 23, II, e 24, XII) para adotar medidas sanitárias, evidenciando o vácuo de coordenação central.

O CNS afirmou que o Ministério da Saúde deixou de exercer sua competência de direção nacional do SUS (Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990), omitindo-se de coordenar a resposta e ignorando recomendações do Conselho.

Fragilidade da PNVS

O Brasil possuía apenas a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pela Resolução CNS nº 588/2018, e, portanto, sem força de lei. O CNS ressaltou que, passados cinco anos de sua criação, não houve iniciativa para transformar a PNVS em lei, mantendo-se lacunas jurídicas relevantes.

Essa fragilidade contrasta com referenciais normativos como a PNPDEC (Lei nº 12.608/2012) e o *WHO Emergency Disaster Risk Management Framework* (2019), que preconizam a institucionalização formal, a gestão de riscos e a participação social como condições indispensáveis para respostas coordenadas a emergências.

Limitações das instâncias de resposta

Durante a crise, estruturas emergenciais como o GEI-ESPII, o Gabinete de Crise e o Comitê de Coordenação de Operações foram criadas em caráter excepcional, sem preparo prévio. O TCU, no Acórdão nº 1.335/2020, registrou o esvaziamento do COE, reduzido a papel consultivo, enquanto decisões estratégicas ficaram concentradas nos secretários do MS. A Portaria GM/MS nº 188/2020, que instituiu o COE-nCoV, não formalizou uma composição plural, em desacordo com os princípios de boa governança e participação.

Problemas identificados durante a pandemia de Covid 19 sob a perspectiva da governança da resposta à Espin.

Manifestações do Conasems, CNS, relatório da Fiocruz/CEPEDES e Acórdãos do TCU, como os Acórdãos nº 1.335/2020, nº 1.888/2020, nº 2.878/2021, nº 2.463/2022 e nº 1.967/2023 - apontaram falhas recorrentes (detalhadas no Anexo III):

a) Rotatividade no Ministério da Saúde;
b) Falhas de liderança e governança;
c) Coordenação insuficiente do MS;
d) Exercício prejudicial da liderança;
e) Atuação descoordenada dos entes federativos;
f) Subnotificação e ausência de política nacional de testagem;
g) Centralização decisória e baixa participação;
h) Plano de Contingência sem critérios claros; e
i) Resultados inefetivos: excesso de mortalidade.

As falhas observadas demonstram que a resposta nacional à Covid-19 foi marcada por fragmentação federativa, judicialização e dependência da conjuntura político-governamental. O cenário não esteve em conformidade às boas práticas de governança do Decreto nº 9.203/2017 e do TCU (2014), bem como as recomendações internacionais da OMS (EDRM/2019).

A esse respeito, ressaltam-se os Acórdãos do Plenário do TCU sobre o tema, dentre os quais os seguintes: 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020, 4.049/2020, 1.873/2021, 2.878/2021, 2.369/2022, 2.463/2022 e 1.967/2023. Os relatórios elaborados pelo TCU, em oito ciclos de avaliação das ações de governança e gestão do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19, detalham diferentes problemas relacionados à governança – e a partir de auditorias realizadas no curso da Espin em comento, de modo que aqui foram citados apenas alguns, a título de ilustração.

A importância dessa análise tem múltiplas razões, dentre as quais duas são destacadas:
- Primeiro, é necessário reconhecer e incorporar as lições aprendidas, para aperfeiçoar as instituições e os processos e para evitar que esses erros se repitam no futuro; e
- Segundo, as causas fundamentais que possibilitaram a ocorrência de grande parte desses fatos constatados durante um evento concretamente vivenciado no país subsistem ao menos parcialmente. Em consequência, persiste o risco de reincidência de problemas em futuras emergências.

1.2 Situação atual

Constatou-se que ocorreram mudanças nas instituições de reposta às ESP após o final da pandemia de Covid-19, como aquelas que foram extintas, além da criação da Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública (CTA-ESP), instituída após o final da pandemia de Covid-19, por meio da Portaria GM/MS nº 440/2023.

As instituições preexistentes, em geral com funções operacionais e de natureza técnica continuam a existir. A SVSA ainda existe, embora com mudanças em sua estrutura e atribuições desde o início da pandemia de Covid-19, nos termos do Decreto nº 11.798, de 28.11.2023. A ela compete, inclusive, coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da Política Nacional de Vigilância em Saúde.

O COE-nCoV deixou de existir, com a revogação da Portaria GM/MS nº 188/2020 pela Portaria GM/MS nº 913, de 22.04.2022, a qual encerrou a Espin então vigente. Entretanto, os

normativos vigentes regulam a instituição, procedimentos e funcionamento do COE, na hipótese de novas ESP. A vulnerabilidade a mudanças frequentes e o risco de interferências prejudiciais ao seu funcionamento subsiste, conforme tratado no ponto específico sobre o COE.

A Secovid deixou de existir, a partir da nova estrutura regimental instituída pelo Decreto nº 11.098/2022, cabendo ressaltar que o MS não forneceu informações requeridas sobre funções que foram desempenhadas pela referida Secretaria durante certo período.

As principais mudanças se referem às instituições criadas a partir do início da Pandemia de Covid-19, para o desempenho de funções estratégicas e críticas, usualmente de coordenação, direção e de centro de governo. A maioria delas deixou de existir, não obstante certas funções essenciais que desempenharam devessem estar permanentemente e formalmente instituídas mediante legislação própria, para pronta ativação em futuras ESP, embora segundo princípios e boas práticas de governança, com adequada representatividade e sem as ambiguidades, superposições ou indefinições apontadas.

O Decreto que instituiu o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 foi revogado pelo Decreto nº 11.077/2022. Já o Decreto nº 10.211/2020, que instituiu o GEI-ESPII, ainda está em vigor. Cabe lembrar, contudo, que as funções de centro de governo foram desempenhadas efetivamente pelo Comitê de crise e não pelo GEI-ESPII, o que pode implicar limitação e perda de oportunidade na documentação e incorporação das lições aprendidas para enfrentamento de ESP futuras.

O Gabinete de Crise da Covid-19 deixou de existir, uma vez que a Portaria GM/MS nº 3.190/2020 previa a duração enquanto perdurasse a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da Covid-19. O Decreto que instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 foi revogado pelo Decreto nº 11.077/2022.

Em recente manifestação de agosto de 2025, o MS destacou que a experiência da Covid-19 e o aumento da frequência de emergências sanitárias evidenciaram lacunas na gestão de riscos, o que motivou a adoção de iniciativas para avançar na construção de uma política de Estado transversal e interministerial. Entre as ações mencionadas estão:
- Fortalecimento do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA), responsável por coordenar preparação, vigilância e resposta, com base no Regulamento Sanitário Internacional;
- Manutenção e aprimoramento do COE (Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública) como instância de coordenação e tomada de decisão;
- Publicação de instrumentos como o Guia para Elaboração de Planos de Contingência (2024) e execução de oficinas e simulados em todos os estados;
- Instituição de grupos de trabalho, como os da Portaria GM/MS nº 1.334/2023 (Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta às Pandemias) e da Portaria GM/MS nº 167/2025 (propostas para ampliar a capacidade nacional de enfrentamento); e
- Planejamento para transformar avanços operacionais e técnicos em política pública perene, garantindo previsibilidade e sustentabilidade das ações.

Adicionalmente, o MS reconhece a necessidade de transformar os citados avanços operacionais e técnicos em uma política pública de Estado perene, transversal e interministerial, garantindo maior previsibilidade, sustentabilidade e institucionalidade às ações de preparação e resposta. Nessa direção ressalta-se também que, dentre outros subsídios a serem considerados, corroborando-se com as proposições dispostas na auditoria, o exame da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e seus respectivos dispositivos também é considerado para endereçar as lacunas da ausência de uma política específica de emergências.

Cabe destacar que, ao contrário do que ocorre com a PNPDEC - Lei nº 12.608/201 - justamente instituída dois anos após os relevantes desastres ambientais registrados no Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco, o Brasil ainda não conta com uma política de Estado específica para o enfrentamento de emergências em saúde pública de importância internacional e/ou nacional, não obstante as evidências de que os insatisfatórios resultados em saúde observados estão relacionados às fragilidades e problemas de governança e que a institucionalização formal de uma política pública de Estado é um dos critérios de aferição da boa governança.

A Lei nº 12.608/2012 oferece elementos aplicáveis a uma política pública de Estado para resposta às ESP, com ajustes. Destacam-se:

a) Institucionalização: cria formalmente a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), com diretrizes, objetivos e abrangência nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, em linha com o paradigma da OMS.
b) Estruturas: institui o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC).
c) Competências: define atribuições específicas e comuns dos entes federados, cabendo à União coordenar o SINPDEC e instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.
d) Participação: assegura a presença de União, estados, DF, municípios, sociedade civil, especialistas e comunidades atingidas.
e) Finalidades: articulação, coordenação e execução de programas e projetos de proteção e defesa civil. O CONPDEC auxilia na formulação e monitoramento da PNPDEC, propondo normas e procedimentos, inclusive para grupos vulneráveis (crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência).
f) Diretrizes: atuação articulada entre entes federativos, prioridade à prevenção, planejamento baseado em pesquisas e riscos, e participação social.
g) Objetivos: reduzir riscos de desastres, garantir continuidade das ações, promover cidades resilientes, desenvolver consciência nacional e orientar comunidades em prevenção e autoproteção.
h) Plano Nacional: define critérios mínimos, prazos de revisão trienal, prestação de contas anual e participação social com audiências e consultas públicas.
i) Gestão: trata da condução de acidentes e desastres, reforçando a integração entre níveis de governo e sociedade.

Ainda que a referida PNPDEC não contenha todos os elementos desejáveis segundo princípios e boas práticas de governança adotados na presente análise, a exemplo da formalização do processo decisório e explicitação da prevenção e precaução enquanto princípios norteadores das decisões, a PNPDEC se aproxima sobremaneira dos critérios propostos.

Conclui-se que as evidências reunidas no presente Achado indicam a relação entre os problemas na resposta governamental à pandemia de Covid-19 e diversos problemas e fragilidades na governança, que por sua vez estão ligados à falta de institucionalização de uma política pública de Estado específica para o enfrentamento de ESP. Em última análise, esta falta pode ser considerada causa mediata ou imediata dos principais problemas relevantes constatados na resposta governamental à pandemia de Covid-19. Em que pese os avanços destacados ao longo do Relatório, subsiste o risco de repetição de problemas iguais ou semelhantes em futuras ESP, tornando o país, o SUS e a população mais vulneráveis às emergências ambientais e em saúde pública.

2. Necessidade de aperfeiçoamento da institucionalização do processo decisório nas ESP.

O objetivo do presente ponto é avaliar se os atos normativos relativos à resposta às ESP estabelecem um processo decisório transparente, fundamentado em evidências, orientado a riscos, motivado pela equidade e pelo fim de atender ao interesse público.

2.1. Princípios e boas práticas da boa governança no processo decisório

O Decreto nº 9.203/2017 estabelece que são princípios da governança pública manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade (Art. 3º, VIII).

Já o Referencial para avaliação de governança em políticas públicas do TCU (BRASIL, 2014b) no contexto do processo decisório, aplica-se um rol de oito princípios (ou características) de boa governança preconizado pela Unescap, quais sejam: participação, orientação a consensos, *accountability*, transparência, responsividade, eficiência e efetividade, estado de direito, equidade e inclusão.

No âmbito da resposta às ESP e relativamente ao processo decisório, representação e participação das partes interessadas, o Conasems, em resposta à solicitação de auditoria da CGU afirma que:

> O processo decisório federativo na saúde deve ser fortalecido como um todo. A Lei 8.080/1990 e a Lei Complementar 141/2012 estabelecem que o planejamento na saúde deve ser ascendente, sendo essencial para a gestão. Os espaços de governança do Sistema Único de Saúde (SUS) têm papel crucial nesse processo de planejamento e devem ser organizados para enfrentar emergências em saúde pública (ESP), como a pandemia de Covid-19.
>
> Ressaltamos a importância de uma gestão técnica, especialmente em órgãos como o Centro de Operações de Emergência (COE), destacando a relevância da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVSA) ou outra entidade com expertise em epidemiologia para liderar essa gestão. (grifo nosso)

O Acórdão TCU nº 1.616/2020 – Plenário cita que, no contexto de gerenciamento de crises – como é o caso da resposta às ESP, é exigida a "tomada de decisão por autoridade legítima para enfrentamento da Covid-19 em contexto de urgência, de precariedade de informações,

num ambiente de incertezas e de pressão para a solução da crise". Um dos riscos apontados pelo TCU na avaliação de governança da resposta à pandemia foi o risco de serem adotadas "decisões não baseadas em questões médicas e científicas resultando em baixa efetividade das medidas adotadas de prevenção e combate à pandemia, desperdícios de recursos públicos e aumento de infecções e mortes".

Exemplo disso são as controvérsias verificadas durante a pandemia de Covid-19, especialmente no que se refere às decisões sobre o uso de medidas não terapêuticas e ao debate entre os impactos econômicos e sanitários dessas ações.

Por essas e outras razões, as decisões relativas às ESP devem seguir os princípios e boas práticas de governança e aqueles preconizados para a resposta às emergências e calamidades, a exemplo de transparência, fundamentação em evidências e ser orientado a riscos. Também é preciso considerar que a preparação e a prontidão da resposta às emergências em saúde são imperativos, de modo que as principais regras do processo decisório devem ser estabelecidas e conhecidas desde antes das ESP, além de proporcionar transparência.

2.2. Princípios da prevenção e da precaução no processo decisório das ESP.

No enfrentamento das ESP, além das boas práticas de governança, destaca-se a necessidade de decisões orientadas pelos princípios da prevenção — previsto no art. 198, II, da Constituição, que prioriza ações preventivas no SUS — e da precaução, aplicável em contextos de incerteza científica.
Segundo Fareña (2020), o princípio da precaução justifica a adoção de medidas eficazes para evitar a propagação de doenças transmissíveis, mesmo quando não há consenso científico pleno, desde que respeitados critérios de proporcionalidade. Esse entendimento foi particularmente relevante na pandemia de Covid-19 e tende a se repetir em futuras emergências.
A aplicação insuficiente ou contraditória desses princípios ajuda a explicar falhas de coordenação e omissões governamentais, que prejudicaram a efetividade da resposta à Covid-19.

2.3. Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

Segundo o STF (ADI 6.341/2020), a Constituição estabelece a competência comum em saúde (CF, art. 23, II e IX) e a concorrente entre União e Estados/DF para legislar sobre proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). O SUS, pela descentralização, exige articulação federativa.

O TCU, em diferentes referenciais de governança, avalia processos decisórios pela institucionalização, liderança e coordenação. Essas três perspectivas foram testadas durante a pandemia.

2.3.1. Ministério da Saúde, SVSA e COE.

A PNVS (Resolução CNS nº 588/2018) e o PRESP (2014) atribuem ao MS, por meio da SVSA, a coordenação das ações de vigilância em emergências de saúde pública, com ativação do COE e uso do Sistema de Comando de Operações (SCO). O PRESP prevê protocolos pré-discutidos e matriz de avaliação de risco.

Na prática, porém, não houve explicitação formal dos critérios decisórios, apenas algoritmos de acionamento do COE. O CNS afirmou que o MS não cumpriu suas competências legais de gestão do SUS (Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990), omitindo-se de articular ciência e controle social. Já o Conasems destacou interferência do Comitê de Crise nos trabalhos do COE, comprometendo a resposta.

O CEPEDES/Fiocruz registrou que a falta de confiança levou os estados a adotar medidas legais próprias, descoordenadas da União. Já publicação conjunta de Conass, Conasems e OPAS/OMS apontou a ausência do MS em orientações técnicas locais, limitando-se a repassar às autoridades subnacionais a decisão sobre retomada de atividades (Portaria GM/MS nº 1.565/2020).

O TCU (Acórdãos nº 1.888/2020, nº 4.049/2020 e nº 1.967/2023) apontou que a partir de abril de 2020, as funções do COE foram avocadas pela Secretaria Executiva/MS e depois pela Secovid (Decreto nº 10.697/2021), sem normativos claros sobre processo decisório. O COE, concebido como instância plural, teve seu papel reduzido e subordinado ao Gabinete de Crise, criado tardiamente (Portaria GM/MS nº 3.190/2020).

2.3.2. Articulação intragovernamental e intergovernamental.

O Comitê de Crise (Decreto nº 10.277/2020) foi instituído para coordenar a resposta, mas sem regras formais de processo decisório ou participação social. O TCU (Acórdão nº 1.616/2020) registrou a ausência de diretriz estratégica clara e de coordenação nacional, acarretando fragmentação federativa.

A superposição entre Comitê de Crise, SVSA e COE gerou indefinição de competências. O Conasems afirmou que o comitê foi criado sem aproveitar a expertise técnica e interferiu nos trabalhos do COE. O CNS reiterou a omissão do MS em articular a resposta com estados e municípios.

O GEI-ESPII (Decreto nº 10.211/2020), que poderia atuar como Centro de Governo, permaneceu inativo durante a pandemia, conforme apontado pelo TCU (Acórdão nº 1.967/2023).

Em síntese, conforme as fontes citadas, o processo decisório no enfrentamento da Covid-19 foi marcado por conflito de competências, centralização na União sem pactuação federativa, criação tardia de instâncias provisórias e limitação das atividades do COE. O resultado foi uma resposta desarticulada, com fragilidades quanto à aderência aos princípios constitucionais (CF, arts. 23, 24 e 196), à PNVS, ao Decreto nº 9.203/2017 (governança), e aos referenciais internacionais da OMS/EDRM (2019).

2.4. Situação atual

Constatou-se que ocorreram mudanças em relação ao processo decisório, especialmente no fortalecimento do COE, contudo, no tocante à institucionalização do processo decisório na resposta governamental às ESP após o final da pandemia de Covid-19 o processo ainda carece de aperfeiçoamento. Em consequência, mesmo com a extinção de determinadas instâncias que exerceram papéis decisórios, subsistem as fragilidades, as lacunas e as condições essenciais em que ocorreram os problemas mais relevantes constatados na pandemia de Covid-19.

Em manifestação de agosto de 2025, o MS reconhece que embora o Brasil disponha de marcos legais e operacionais importantes para a gestão de emergências em saúde pública, há ainda espaço para o aperfeiçoamento do processo decisório. Nesse sentido, destaca a atuação do COE como a principal estrutura organizacional atual do MS voltada à coordenação da resposta e à tomada de decisão durante emergências em saúde pública.

Ainda, em alinhamento com as lições aprendidas durante a pandemia de covid 19, o MS finalizou a proposta do Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta às Pandemias, documento estabelece diretrizes e medidas para o enfrentamento de ameaças pandêmicas, em conformidade com os princípios do SUS e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o RSI e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

O Ministério da Saúde reafirma seu compromisso com o fortalecimento da governança e da capacidade nacional de resposta a emergências em saúde pública, por meio da qualificação dos processos decisórios. Segundo o MS, os esforços em curso visam garantir maior previsibilidade, agilidade e legitimidade institucional, assegurando respostas mais integradas e eficazes frente aos desafios sanitários atuais e futuros.

Assim, constata-se que o processo decisório aplicável às ESP no país é de natureza geral, fragmentado por esferas governamentais e não formalmente instituído segundo princípios e boas práticas de governança. Carece de transparência, orientação a riscos, participação social e fundamentação nos princípios da precaução e da prevenção, o que prejudica a coordenação nacional e aumenta o risco de repetição das falhas observadas durante a pandemia de Covid-19.

Diante disso, destaca-se a necessidade de institucionalizar de forma permanente a função de Centro de Governo, com protocolos previamente definidos para pronta ativação em futuras emergências. O processo decisório deve ser pautado em evidências científicas, conformidade legal, expertise técnica e representatividade das partes interessadas, fortalecendo a coordenação federativa e garantindo deliberações legítimas e eficazes.

3. Necessidade de instituir um conselho deliberativo plural no âmbito de uma política de Estado de resposta às ESP.

O objetivo do presente ponto é avaliar se os atos normativos que institucionalizam o enfrentamento de ESP estabelecem adequadamente a participação efetiva das partes interessadas no processo decisório e na formulação de políticas, inclusive os entes públicos e instâncias de natureza técnico-científicas correlatas às ações de enfrentamento das ESP.

O presente trabalho adota enquanto critério de avaliação a participação efetiva das partes interessadas nas instâncias e respectivos processos decisórios, assim como a institucionalização formal dos processos decisórios referentes à política pública (BRASIL, 2014b; Decreto 9.203/2017; Lei 8.142/1990).

No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o Decreto nº 9.203/2017 estabelece enquanto diretriz definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais (Art.4º, X).

Segundo o TCU (BRASIL, 2014b), a participação é um dos oito componentes que viabilizam uma boa governança em políticas públicas. O mencionado Referencial do TCU cita:

> Na rede de políticas públicas, há a dependência mútua entre os diversos atores envolvidos em uma finalidade comum, haja vista que, isoladamente, não conseguem alcançar seus objetivos sem a participação dos demais partícipes. A cooperação entre atores, desse modo, torna-se questão central para explicar o sucesso ou o fracasso das políticas públicas (HILL e HUPE, 2002). (grifo nosso)
>
> [...] é importante que exista uma boa coordenação dessas políticas. A coordenação deve existir horizontalmente, englobando atores da mesma esfera de governo e nível hierárquico, e também verticalmente, com atores de outras esferas de governo e de diferentes níveis hierárquicos na Administração Pública (MARTINS, 2003).
>
> [...] uma gestão democrática, transparente e aberta à participação estaria em maior conformidade com princípios gerais e contemporâneos da governança do Estado e de sua relação com a sociedade.

Ainda em relação ao processo decisório, o Conasems, em resposta à CGU, destacou que deve ser fortalecido, em conformidade com a Lei nº 8.080/1990 e a LC nº 141/2012, que preveem planejamento ascendente no SUS. Ressaltou ainda o papel crucial dos espaços de governança no enfrentamento das ESP e a necessidade de gestão técnica no COE, sob liderança da SVSA ou de instância com expertise em epidemiologia.

Considerando o exposto, na resposta às ESP espera-se uma definição clara e formal das competências das principais partes interessadas envolvidas na política pública (matriz de responsabilidades), de forma que seja possível a identificação dos objetivos, papéis, responsabilidades, recursos e obrigações de todos os envolvidos, incluindo-se abordagem para tratar resolução de conflitos, identificar e dividir riscos e oportunidades e estabelecer formas de revisão, avaliação e monitoramento (TCU, 2014b).

3.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

Os atos normativos que institucionalizam a resposta às Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) não garantiram a participação efetiva das partes interessadas no processo decisório. Durante a pandemia de Covid-19, decisões foram tomadas com pactuação limitada com Estados, DF e Municípios, o que levou os entes subnacionais a recorrer ao STF (ADI 6.341/2020 e ADI 6.343/2020) para assegurar sua competência concorrente e comum (CF, arts. 23 e 24).

O arcabouço legal do SUS prevê participação social nas Leis nº 8.080/1990 e 8.142/1990, que instituem conselhos e conferências de saúde, além da PNVS (Res. CNS nº 588/2018), que estabelece a cooperação interfederativa e a participação social. Contudo, esses mecanismos não foram efetivamente acionados no processo decisório da pandemia.

Segundo o MS (Nota Técnica nº 30/2023), houve participação formal de Conass, Conasems, CIT, CTA-ESP (Portaria GM/MS nº 440/2023) e do COE. Todavia, o CNS afirmou que o MS não exerceu plenamente suas competências de gestão do SUS, e o Conasems destacou a interferência do Comitê de Crise da Casa Civil nos trabalhos técnicos do COE, comprometendo sua eficácia. O CEPEDES/Fiocruz registrou que a falta de confiança no governo federal levou a respostas fragmentadas e pouco coordenadas pelos estados.

O TCU, no Acórdão nº 1.616/2020, observou que o Comitê de Crise foi criado sem assento permanente para entidades técnico-científicas, limitando a pluralidade. Já o Acórdão nº 335/2022 apontou que o MS não definiu critérios gerais para quarentena, permitindo que cada ente subnacional adotasse parâmetros próprios, gerando insegurança na população e comprometendo a adesão às medidas.

O STF, ao analisar a MP nº 926/2020, reforçou que a emergência sanitária não autoriza a concentração de poder decisório sem contrapesos democráticos. O Tribunal afirmou que o direito à saúde exige coordenação federativa com base em evidências científicas e recomendações da OMS, afastando interpretações que restringissem a atuação de estados e municípios.

O Conass, em conjunto com Conasems e OPAS/OMS, publicou em 2020, orientações locais de gestão sem participação do MS, em resposta à Portaria GM/MS nº 1.565/2020, que delegava a decisão sobre retomada de atividades às autoridades locais, sem diretrizes nacionais. Em 2024, o Conasems (Ofício nº 0062/2024) reconheceu a falta de representatividade e recomendou ampliar espaços formais de diálogo para garantir maior legitimidade democrática no processo decisório.

Em suma, a pandemia demonstrou que, apesar da previsão constitucional (CF, art. 198) e legal (Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990), faltaram mecanismos eficazes de participação federativa e social no processo decisório. O resultado foi um cenário de centralização da União, conflitos de competência, insegurança jurídica e falhas de coordenação, contrariando os princípios do Decreto nº 9.203/2017 sobre governança pública, a PNVS, e as recomendações internacionais da OMS (RSI/2005 e EDRM/2019).

3.2 Situação atual

Em manifestação de agosto de 2025, o MS concorda que a falta de um arranjo estável e plural para decisões durante emergências, como na pandemia de Covid-19, prejudicou a coordenação e levou a respostas fragmentadas. Reconhece a importância de incluir órgãos técnicos, instituições científicas, conselhos de saúde e gestores estaduais e municipais para dar legitimidade e qualidade às decisões. Neste sentido, argumenta que já retomou e fortaleceu os Centros de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) como principal instância de gestão, com ativação regulada por portarias e participação ampliada de atores estratégicos, além de adotar a metodologia do Sistema de Comando de Incidentes e criar a Câmara Técnica de Assessoramento (CTA-ESP), permanente e tripartite, para apoiar decisões.

Entende o MS que, embora o Brasil ainda não possua formalmente um "conselho deliberativo nacional permanente" voltado exclusivamente às emergências em saúde pública, o modelo do COE tem se consolidado como instância legítima de governança e pactuação de decisões estratégicas. Sua composição plural, que inclui áreas técnicas do Ministério da Saúde, agências reguladoras, instituições científicas, organismos internacionais, conselhos de saúde e representantes das gestões estaduais e municipais, assegura a deliberação conjunta e embasada tecnicamente, respeitando os princípios do SUS e da saúde pública.

Conclui-se que os atos normativos que institucionalizam o enfrentamento de ESP ainda não estabelecem adequadamente a participação efetiva das partes interessadas no processo decisório e na formulação de políticas, inclusive os entes públicos e instâncias de natureza técnico-científica correlatos às ações de enfrentamento das ESP, nem da sociedade civil.

Já a PNPDEC se aproxima dos critérios propostos para o presente trabalho pois estabelece aspectos relevantes, a participação ampla das partes envolvidas na política:

a) O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) contempla a participação de órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil, possibilitando também a participação de organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa; e

b) O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), que contará com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber.

Por fim, as análises realizadas e as evidências reunidas no trabalho, colhidas de diferentes fontes, indicam que a institucionalização formal da participação nas instâncias decisórias estratégicas poderia reduzir substancialmente os riscos de que, em futuras emergências em saúde pública, ocorram conflitos, antagonismos, descoordenação, falta de colaboração e de alinhamento.

4. A atuação do Centro de Operações de Emergências (COE) está sujeita a limitações para o desempenho na resposta às ESP.

No presente tópico será avaliada a institucionalização do COE, uma estrutura organizacional essencial para a resposta às ESP no país, pois além de ser de natureza técnica e especializada, a ela cabe desempenhar funções de coordenação, articulação e integração, em âmbito nacional. Ressalta-se que o desempenho dessas funções ocorre num contexto de relações interfederativas, de relações de não subordinação e de interdependência com outras partes interessadas e necessárias à eficácia e efetividade da política pública. Também é preciso ter em conta a natureza descentralizada e participativa do SUS (Lei 8.142/1990).

O Referencial de Avaliação de Políticas Públicas do TCU cita Martins (2003), pontuando:

> "[...] é importante que exista uma boa coordenação dessas políticas. A coordenação deve existir horizontalmente, englobando atores da mesma esfera de governo e

> nível hierárquico, e também verticalmente, com atores de outras esferas de governo e de diferentes níveis hierárquicos na Administração Pública.

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) é uma instituição que desempenha papel essencial na resposta às ESP, dado o seu papel de coordenação, de articulação e de integração entre os atores envolvidos. Trata-se de instância técnica e operacional e que é preexistente à pandemia de Covid-19. A cada Espin declarada corresponde um COE específico, que ao final é desativado. Observe-se, porém, a necessidade de regras e protocolos formais permanentes (mas não imutáveis) – pressupõe-se que são preestabelecidos, de modo a possibilitar a pronta e efetiva resposta às ESP e atuação do COE, ainda que em tempos nos quais não haja emergências declaradas.

Como visto, o COE tem como objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos e é o responsável pela coordenação das ações de resposta às emergências em saúde pública. E os atores envolvidos na resposta às ESP são diversos, públicos e privados e das diferentes esferas governamentais.

4.1. Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

A participação de atores externos ao Governo Federal no COE não foi formalmente instituída nos principais normativos. O PRESP/MS e a Portaria GM/MS nº 188/2020 criaram o COE-nCoV, mas apenas a Portaria GM/MS nº 3.190/2020 previu a inclusão de Conass, Conasems e OPAS, e mesmo assim no âmbito do Gabinete de Crise.

O COE foi instituído sob responsabilidade da SVSA/MS, em conformidade com a PNVS (Resolução CNS nº 588/2018) e com os decretos presidenciais que atribuem à SVSA a coordenação da vigilância em saúde (Decretos nº 9.795/2019, nº 11.098/2022, nº 11.358/2023, nº 11.391/2023 e nº 11.798/2023). Contudo, durante a pandemia, o MS promoveu mudanças institucionais que fragilizaram a coordenação, sem observar princípios de governança e sem clareza de competências entre SVSA, COE e novas estruturas criadas.

4.1.1. Mudanças de responsabilidade na gestão do COE, com prejuízo para a resposta à pandemia de Covid-19

Embora a Portaria GM/MS nº 188/2020 atribuísse o COE à SVSA, já em abril de 2020 sua gestão foi transferida à Secretaria Executiva do MS, segundo a Nota Técnica nº 31/2023-CGCIEVS/DEMSP/SVSA/MS. O TCU (Acórdão nº 1.888/2020) apontou que a justificativa foi alinhar decisões ao Comitê de Crise da Casa Civil (Decreto nº 10.277/2020), mas advertiu para riscos de perda de coordenação e de conhecimento técnico.

O Tribunal também observou que o COE deixou de propor aquisições e contratações (competência prevista no art. 3º, V, b da Portaria nº 188/2020), transferindo tais decisões a secretarias finalísticas (Acórdãos TCU nº 4.049/2020 e nº 676/2022). Segundo o TCU, em vez de adequar o funcionamento ao normativo, o MS ajustou os normativos à prática, enfraquecendo a função estratégica do COE.

Posteriormente, a Portaria GM/MS nº 3.190/2020 criou o Gabinete de Crise da Covid-19 e alterou a composição do COE, que passou a ser coordenado pela Secretaria Executiva e não mais pela SVSA. Essa mudança, formalizada apenas em novembro de 2020, refletiu a fragmentação institucional.

O CNS declarou que o MS não exerceu suas competências de direção do SUS. O Conasems reforçou que o COE deveria ter uma gestão técnica tripartite, mas sua atuação foi prejudicada pela interferência do Comitê de Crise e pela criação da Secovid (Decreto nº 10.697/2021), que desarticulou a integração entre vigilância e atenção primária.

Segundo o CEPEDES/Fiocruz, apenas um terço dos estados criou COE no início da pandemia, o que seria reflexo da falta de confiança na coordenação nacional. Já o TCU (Acórdãos nº 1.967/2023 e nº 2.369/2022) destacou que o encerramento da Espin ocorreu de forma abrupta, sem plano de mitigação, gerando riscos de descontinuidade em vacinas, testagem e assistência a pacientes.

O CNS, em ofício de julho/2020, solicitou a inclusão do controle social no COE, defendendo-o como espaço com maior capacidade para garantir respostas efetivas. O Conasems, em nota de 25.03.2020, reiterou a necessidade de estabilidade institucional nos espaços de governança do SUS.

Em síntese, as sucessivas mudanças na gestão do COE, a sobreposição de instâncias (Comitê de Crise, Secovid) e a ausência de representatividade formal resultaram em fragilidade de coordenação, perda de aprendizado institucional e descontinuidade na resposta, contrariando a PNVS, a Lei nº 8.142/1990 e os referenciais de governança do TCU e da OMS.

4.2 Situação atual

Mesmo com a extinção de determinadas instâncias que exerceram temporariamente papéis de coordenação e decisórios na resposta governamental à pandemia de covid-19, e que assumiram ao menos em parte funções correspondentes, análogas ou similares àquelas anteriormente previstas para o COE, assim como o retorno de determinadas atribuições à SVSA/MS, com a mudança de governo, subsistem as fragilidades, as lacunas e as condições essenciais que possibilitaram a ocorrência dos problemas mais relevantes constatados na pandemia de Covid-19, inclusive a incidência de problemas que influenciaram o desempenho da função originalmente prevista para o COE.

Cabe notar, entretanto, uma prática tendente à melhoria da governança, embora a iniciativa isolada não caracterize uma mudança essencial nas causas subjacentes aos problemas constatados, ou seja, nas normas de institucionalização do COE. Trata-se da instituição do Centro de Operações de Emergências para a situação de chuvas intensas e inundações na Região Sul, no âmbito do MS, por meio da Portaria GM/MS nº 3.697, de 3.05.2024 que, ao contrário do que foi instituído formalmente para o COE até a pandemia de Covid-19, agora conta com representantes de partes interessadas externas ao órgão e/ou ao Governo Federal, como é o caso da Anvisa, Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; CONASS; CONASEMS; e OPAS. São instituições representativas da saúde pública e de entes públicos das demais esferas de governo, o que tende a favorecer o aperfeiçoamento da governança na resposta às ESP.

Na manifestação de agosto de 2025, o MS reafirmou que, desde 2023, retomou o protagonismo da SVSA e do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP) na condução das respostas, com o COE voltando a ser a principal estrutura coordenadora. A ativação do COE passou a ser regida por portarias específicas, com definição de competências e composição formal, incluindo a participação de Anvisa, Fiocruz, CONASS, CONASEMS e OPAS/OMS, como exemplificado na Portaria GM/MS nº 3.697/2024.

Como consequência, a não institucionalização adequada e formal do desempenho das funções técnicas e especializadas do COE não favorece a efetiva coordenação, articulação e integração na resposta governamental às ESP, em âmbito nacional, no âmbito do Ministério da Saúde e entre setores do Governo Federal.

Os problemas constatados no desempenho das funções do COE na resposta governamental à pandemia de Covid-19 são consequência do ambiente de fragilidades na governança. Dado o contexto extraordinário de resposta às ESP, envolvendo cenário de crise, alta complexidade, incertezas, relações de interdependência e natureza do SUS, caracterizada por participação e descentralização, é necessária a instituição de norma adequada relativa à atuação dos diversos órgãos, instituições e esferas de governo envolvidos, com a definição e delimitação clara e formal das competências, papéis e responsabilidades das principais partes interessadas envolvidas na política pública (TCU, 2014).

5. Fragilidade da institucionalização de mecanismos de liderança pelo MS prejudicou a coordenação no enfrentamento de emergência em saúde pública.

Um governo catalisador é o que não assume sozinho o papel de implementar políticas públicas, mas que harmoniza a ação de diferentes agentes sociais na solução de problemas coletivos, o que demanda a participação efetiva das partes interessadas nos processos decisórios. Coordenação não significa controle central, tampouco a eliminação da autonomia de Ministros no desenvolvimento de políticas, mas sim fazer com que diversos sistemas institucionais que formulam políticas trabalhem juntos.

O Decreto nº 9.203/2017 considera como uma das diretrizes da governança pública "articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público".

No contexto brasileiro, a organização do SUS é delineada pela Constituição e pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que estabelecem que o SUS se orientará pelo princípio da descentralização[2], de modo a garantir atuação coordenada em todos os níveis de governo, o que tem especial relevância no contexto do federalismo cooperativo[3] brasileiro, que pressupõe compromissos contínuos entre os diferentes níveis de governo.

Nessa toada, nos termos da Lei nº 6.259, de 30.10.1975, compete ao MS definir, em Regulamento, a organização e as atribuições dos serviços incumbidos da ação de Vigilância

[2] A descentralização é a transferência de uma série de poderes, responsabilidades e recursos do governo central a governos subnacionais que possuem algum grau de autonomia (OCDE, 2019, apud BRASIL, 2021).

[3] O princípio da cooperação, definido no art. 23 da Constituição Federal, representa o fio condutor do êxito das políticas descentralizadas, e isso, geralmente, caminha lado a lado com os mecanismos de governança multinível institucionalizados, baseados no relacionamento colaborativo e alinhado entre *stakeholders* (BRASIL, 2021).

Epidemiológica[4], promover a sua implantação e coordenação. No mesmo sentido, de acordo com a PNVS, são responsabilidades da União, e compete ao MS, por intermédio da SVS e da Anvisa, a gestão da Vigilância em Saúde no âmbito da União, compreendendo coordenar, em âmbito nacional, as ações de vigilância em saúde, nas emergências em saúde pública de importância nacional e internacional, em consonância com o RSI, bem como cooperação com Estados, DF e Municípios em situações de emergências em saúde pública.

Ressalta-se que uma das diretrizes da PNVS, fixada no art. 8º, I, da Resolução nº 588/2018, é a "articulação e pactuação de responsabilidades das três esferas de governo, respeitando a diversidade e especificidade locorregional". Isso demanda a mobilização de recursos considerando as diferentes capacidades dos entes federativos e as desigualdades estruturais que tornam a condução do processo de descentralização política particularmente complexa durante crises como a da Covid-19.

A governança interfederativa e multinível envolve o compartilhamento de responsabilidades e ações, buscando coordenação e cooperação para o alcance de resultados comuns. Além da integração vertical (entre governos de diferentes esferas nacional e subnacional) e da integração horizontal (entre órgãos e entidades de um mesmo ente federativo), a governança também abrange as relações entre entes federados e uma ampla variedade de atores externos que se interessam pelos resultados das políticas públicas.

É dizer que os mecanismos de coordenação são fundamentais, alcançando as relações tecidas nos diversos níveis governamentais e as novas formas de governança, com o olhar voltado para as diferentes realidades territoriais (BRASIL, 2021).

Em arremate, registra-se que os Mecanismos de Coordenação são um dos seis componentes do modelo de avaliação da governança multinível do TCU (BRASIL, 2021), correspondendo ao alinhamento de diretrizes e objetivos da política, definição de programação plurianual, coordenação vertical e horizontal.

Critérios atinentes à coordenação e liderança podem ser encontrados especificamente em todas as perspectivas de governança. Na perspectiva organizacional, por exemplo, a liderança é crucial para promover integridade e competência. Na perspectiva de políticas públicas, a coordenação entre os diversos *stakeholders* é essencial para alcançar resultados eficazes, com definição estratégica clara, supervisão eficiente, envolvimento das partes interessadas, gerenciamento de riscos e promoção da transparência e responsabilidade. Dada a relevância para este trabalho, essas duas perspectivas são aprofundadas no anexo deste Relatório.

5.1 Situação observada durante a pandemia de Covid-19

Apesar da existência de mecanismos de resposta, o MS enfrentou obstáculos na liderança da pandemia, resultando em tensões federativas e resposta desarticulada. A fragilidade da liderança sanitária e a fragmentação institucional prejudicaram a coordenação nacional,

[4] A ação de Vigilância Epidemiológica compreende as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde.

mesmo diante da ativação do COE-nCoV (Portaria GM/MS nº 188/2020) e do Plano de Contingência Nacional.

5.1.1 Coordenação intergovernamental

A Lei nº 8.080/1990 reconhece o Conass e o Conasems como representantes estaduais e municipais, além das instâncias CIB, CIT e CIR (Decreto nº 7.508/2011). O MS, por meio do Decreto nº 9.795/2019, atribuía à SVS e ao Departamento de Gestão Interfederativa a função de articular ações interfederativas. Após a pandemia, a criação do DEMSP/SVSA (Decretos nº 11.098/2022 e nº 11.358/2023) buscou fortalecer a preparação e resposta às emergências.

Na prática, porém, o Plano de Contingência não foi plenamente executado, e a falta de pactuação federativa resultou em litígios no STF (ADI 6341, ADPF 672, ADPF 754, entre outros). O TCU, nos Acórdãos nº 1.335/2020 e nº 1.888/2020, apontou falhas na disponibilização de recursos e constatou que o COE-nCoV não exerceu plenamente a função de coordenação, dividindo competências com a Casa Civil.

A instituição do Gabinete de Crise (Portaria GM/MS nº 3.190/2020) e do Comitê Nacional de Coordenação da Covid-19 (Decreto nº 10.659/2021) não solucionou os problemas, levando o TCU (Acórdão nº 1.873/2021) a recomendar maior fiscalização pelos conselhos de saúde.

5.1.2 Coordenação intersetorial

A Lei nº 8.080/1990 prevê comissões intersetoriais nacionais, subordinadas ao CNS, para articular políticas além da saúde. Durante a pandemia, no entanto, houve sobreposição de instâncias: GEI-ESPII (Decreto nº 10.211/2020), Comitê de Crise (Decreto nº 10.277/2020) e CCOP (Decreto nº 10.289/2020). O TCU (Acórdão nº 1.888/2020) criticou a indefinição de competências, e o Conasems (Ofício nº 0062/2024) apontou a interferência do Comitê de Crise nos trabalhos técnicos do COE.

O TCU (Acórdão nº 2.369/2022) confirmou ausência de estratégia clara no Centro de Governo, enfraquecendo a ação intersetorial. A Lei nº 14.210/2021, de 30.09.2021, instituiu a decisão coordenada, mas sua aplicação foi tardia e incipiente na pandemia.

5.1.3 Aspectos que demandam ação coordenada durante uma Espin

Entre os aspectos críticos que exigem coordenação nacional destacam-se:
a) protocolos nacionais de testagem e notificação compulsória;
b) funcionamento de hospitais de campanha e leitos;
c) política de vacinação;
d) controle migratório e monitoramento de viajantes;
e) medidas não farmacológicas;
f) aquisição de respiradores; e
g) aquisição de medicamentos para o SUS.

A experiência desses aspectos observados durante a pandemia está detalhada no Anexo IV deste Relatório.

5.2. Situação atual

No dia 17.04.2022, após 26 meses da declaração da emergência em saúde pública, o Ministro de Estado da Saúde anunciou o fim da Espin, o que foi formalizado por meio da Portaria GM/MS nº 913/2022, de 22.04.2022. Nos termos da referida Portaria, o MS ficou encarregado de orientar os Estados, o DF e os Municípios em relação a continuidade das ações e medidas presentes no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus, com base na constante avaliação técnica dos possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessárias ações para seu enfrentamento.

O Acórdão TCU nº 2.369/2022 – Plenário, de 19.10.2022, observou uma deficiência notável no planejamento estruturado por parte da Secovid para o término da Espin, especialmente no que tange à continuidade das ações de saúde pública essenciais, como vacinação, testagem e atendimento a pacientes com Covid-19 e manifestações pós-Covid. Essa lacuna na gestão criaria um risco de descontinuidade nos esforços de enfrentamento à pandemia, potencializando as consequências sobre a morbidade e mortalidade ainda decorrentes da doença.

Mais recentemente, foi instituída a Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública (CTA-ESP) pela Portaria GM/MS nº 440/2023, de 03.04.2023, com caráter consultivo, tendo como uma de suas competências prestar apoio técnico-científico para a tomada de decisões das autoridades de saúde nos níveis federal, estadual e municipal, especialmente em ESP. A CTA-ESP atua como um órgão consultivo para avaliar aspectos técnicos e científicos críticos no manejo de emergências de saúde.

Além disso, vale sublinhar que, por meio da Portaria GM/MS nº 1.334, de 22.09.2023, o MS instituiu Grupo de Trabalho (GT), com a finalidade de elaborar plano estratégico para prevenção, preparação e resposta às pandemias, do qual participam, além das Secretarias do MS, a Anvisa, a ANS, o Conass, o Conasems, a Fiocruz e o CNS.

Por meio de expediente encaminhado a esta equipe de auditoria, o CNS avaliou que a criação de grupo de trabalho com participação do controle social e dos entes do SUS é essencial para definir diretrizes de um plano nacional de enfrentamento de pandemias, desde que articulado com estados e municípios. As diretrizes deveriam contemplar:

1. Compreensão da complexidade da pandemia e panorama epidemiológico, considerando desigualdades sociais e estratégias de contenção.
2. Dimensões ecossociais e bioéticas, fortalecendo o princípio de saúde única.
3. Fortalecimento do SUS, com redes regionalizadas, vigilância articulada à APS, pacto federativo, financiamento ampliado, valorização do trabalho em saúde e proteção psicossocial.
4. Ciência e tecnologia, com incentivo à pesquisa, produção industrial e insumos estratégicos.
5. Informação em saúde e TI, garantindo sistemas integrados.
6. Proteção social, seguridade, emprego e renda.
7. Segurança alimentar e melhores condições de vida.

8. Dimensões político-culturais e direitos humanos, com atenção a idosos, mulheres, população negra, indígena, LGBTQIAP+, migrantes, refugiados, pessoas privadas de liberdade, em situação de rua ou com deficiência.

O CNS também ressaltou a necessidade de estratégias para sequelas pós-pandemia, como a Covid longa. Na Recomendação nº 13/2022, defendeu investimentos em vigilância, pesquisas e protocolos de rede de cuidados. O MS apresentou proposta em 2024, acolhendo essas demandas. O TCU (Acórdão nº 1.967/2023 - Plenário) registrou diretrizes ministeriais para organizar a rede de cuidados pós-Covid desde 2021.

As falhas de coordenação tiveram causas como: desigualdades regionais, políticas sem pactuação, ausência de plano nacional articulado, conflitos entre níveis de governo e competição por recursos (OCDE 2020). O TCU (Acórdão nº 1.616/2020) concluiu que a falta de diretriz estratégica clara comprometeu a efetividade, ocasionando perda de oportunidades de fortalecimento do SUS e da segurança sanitária nacional.

Em manifestação de agosto de 2025, o MS informa que em resposta aos desafios evidenciados especialmente durante a pandemia de Covid-19, foi instituído, por meio da Portaria GM/MS nº 167, de 11.03. 2025, o GT interinstitucional com a missão de elaborar uma proposta de Política de Estado para prevenção, preparação e resposta a surtos, epidemias e pandemias e outras emergências em saúde pública, desastres ambientais e eventos relacionados à emergência climática, bem como a criação de uma nova institucionalidade federal especializada voltada à coordenação e execução dessas ações.

Entre as ações já adotadas, destaca que foram revalorizados o papel da SVSA e a liderança do DEMSP, que tem conduzido uma estratégia nacional estruturada em oficinas e exercícios simulados.

Para o futuro, o MS planeja criar uma institucionalidade federal especializada, com autonomia técnica, orçamento próprio e gestão tripartite, sustentada por minuta legislativa prevista para o segundo semestre de 2025. O MS destaca que esta proposta está contando com a colaboração e participação de representantes da Fiocruz, CONASS, Conasems, OPAS/OMS, Abrasco, Cepedisa/USP e outros especialistas.

Conclui-se que o MS, a partir do apontado pelo TCU, Abrasco e CNS, não cumpriu a contento o papel na coordenação nacional do SUS durante o enfrentamento da pandemia, o que culminou em ações desalinhadas entre os entes federativos. Com efeito, a gestão da crise caracterizou-se por conflitos com governos locais. As falhas de coordenação no federalismo brasileiro e as tensões entre diferentes níveis de governo resultaram em uma resposta fragmentada à pandemia.

6. Fragilidade dos mecanismos institucionalizados para a coordenação da comunicação entre os diferentes níveis de governo e com a população.

O acesso à informação é um direito fundamental inscrito no art. 5º da Constituição Federal, e a publicidade, princípio do art. 37 da CF/1988, integra os pilares da Administração Pública. O Decreto nº 9.203/2017 reforça a transparência e a *accountability* como fundamentos da governança pública, prevendo a comunicação aberta e voluntária dos resultados e a manutenção de processos decisórios baseados em evidências e participação social (§3º do art. 37). Nesse contexto, o Acórdão TCU nº 2.092/2020 – Plenário estabeleceu critérios de avaliação da transparência no enfrentamento da Covid-19, com destaque para a transparência qualificada, entendida como aquela que possibilita às partes interessadas tomar decisões com base nas informações fornecidas.

No SUS, a participação social é assegurada principalmente pelos conselhos de saúde – órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, compostos por representantes do governo, usuários, profissionais de saúde e prestadores – e pelas conferências de saúde, realizadas a cada quatro anos (ou extraordinariamente), com caráter ascendente (municipais, estaduais e nacional) e ampla representatividade. Ambas têm previsão legal e se distinguem por garantir formulação de políticas e controle social de forma institucionalizada.

Durante as ESP, normas como a PNVS (Resolução CNS nº 588/2018), a Lei nº 6.259/1975 e as diretrizes da OMS e da OPAS indicam que uma estratégia de comunicação coordenada e tempestiva é indispensável para orientar a população, profissionais de saúde e gestores sobre sintomas, notificação de casos, disponibilidade de leitos, medidas preventivas, tratamentos e eficácia vacinal. O combate à infodemia requer a colaboração entre instituições científicas (como Fiocruz), entidades federativas (Conass, Conasems), conselhos de saúde, órgãos governamentais e mídia, assegurando a circulação de informações confiáveis.

Por fim, destaca-se que a comunicação em saúde deve ser inclusiva e adaptada, considerando públicos com baixa escolaridade ou acesso limitado à tecnologia. Isso demanda múltiplos canais – mídia tradicional, redes sociais, sítios oficiais e aplicativos móveis – além de canais institucionais de consulta e participação da sociedade civil, de modo a garantir decisões fundamentadas em evidências e legitimadas democraticamente.

6.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

Segundo a Nota Técnica nº 34/2023-CGCIEVS/DEMSP/SVSA/MS, o MS adotou ferramentas de comunicação voltadas à população: e-mail exclusivo, número de WhatsApp, TeleSUS (Disque Saúde 136, *chatbot*, aplicativo Coronavírus SUS e busca ativa), além de boletins epidemiológicos, informes técnicos, painéis e clippings de notícias articulados à Rede CIEVS (Portaria GM/MS nº 4.661/2022). Também foi instituída a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar – Renaveh (Portaria GM/MS nº 1.694/2021).

Entretanto, desde junho de 2020, surgiram críticas da OMS e da Abrasco sobre a falta de transparência e confiabilidade dos dados de casos e óbitos, o que levou o Conass e o consórcio

de veículos de imprensa a sistematizarem os dados diretamente das secretarias estaduais. O TCU, no Acórdão nº 1.888/2020 – Plenário, registrou o enfraquecimento da comunicação pública após o fim das coletivas diárias previstas no Plano de Contingência Nacional. A Corte determinou ajustes conforme o Decreto nº 9.203/2017, ressaltando a necessidade de comunicação analítica, tempestiva e transparente, em consonância com padrões internacionais como o NIMS.

A Suprema Corte, na ADPF 690-MC-REF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.11.2020), decidiu que a interrupção abrupta da divulgação de dados epidemiológicos configurou descumprimento dos princípios da publicidade e transparência da Administração Pública e ao direito constitucional à saúde.

Somente em junho de 2021, mais de um ano após o início da pandemia, a Secom apresentou ao TCU um plano de comunicação do MS, fundamentado em três eixos: o reforço da importância das medidas não farmacológicas, a vacinação e a testagem da população. medidas não farmacológicas, vacinação e testagem. Em agosto de 2021, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 – CTAI Covid-19 (Portaria GM/MS nº 1.841/2021) foi criada para subsidiar tecnicamente o PNI e propor ações de disseminação de informações à população.

Apesar disso, o TCU, no Acórdão nº 1.873/2021 – Plenário, observou que não houve fortalecimento da política de comunicação para induzir o comportamento preventivo da população, tampouco coordenação com estados e municípios para unificar mensagens. Situação semelhante foi constatada no Acórdão nº 2.369/2022 – Plenário, que destacou a falta de um plano claro de comunicação para o período pós-Espin, deixando a população sem orientações adequadas frente à persistência do vírus e suas variantes.

Em síntese, embora o MS tenha adotado mecanismos de informação e canais de contato, a ausência de coordenação nacional e de estratégia integrada de comunicação prejudicou a clareza, a transparência e a eficácia das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, reforçando críticas de órgãos de controle.

6.1.1 Combate a notícias falsas

A disseminação de *fake news* configurou-se, durante a pandemia, como prática organizada voltada a ganhos econômicos ou políticos, veiculada por mídias tradicionais e redes sociais. Essa prática prejudicou medidas de prevenção adotadas por autoridades sanitárias, descredibilizou dados científicos e gerou confusão na população, agravando riscos de contaminação, sobrecarga do sistema de saúde e aumento de óbitos.

O Ministério da Saúde limitou suas ações ao canal Sem Fake News, via WhatsApp, que permitia o envio de mensagens para verificação. Entre 22.01.2020 e 24.04.2020, foram recebidas 77 mil mensagens (3 mil diárias), das quais 85% eram falsas, 5% verdadeiras e 10% dúvidas sobre Covid-19. As respostas eram dadas ao cidadão e publicadas no portal eletrônico saude.gov.br/fakenews, atualmente fora do ar.

Em síntese, apesar de representar iniciativa relevante de checagem, a medida mostrou-se restrita diante da escala da desinformação, sem articulação com estratégias mais amplas de comunicação pública ou integração com instâncias de governança em saúde.

6.2 Situação atual

O Sistema de Participação Social foi instituído, em 31.01.2023, pelo Decreto nº 11.407, com a finalidade de estruturar, coordenar e articular as relações do Governo Federal com os diferentes segmentos da sociedade civil na aplicação das políticas públicas. O Sistema compreende, como órgão central, a Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, tendo, como órgãos setoriais, as Assessorias de Participação Social e Diversidade dos Ministérios e as unidades administrativas responsáveis pela área de participação social.

Acrescenta-se que, de acordo com o Decreto nº 11.798/2023, que atualizou a estrutura regimental do MS, a SVSA tem a competência de propor ações de educação, comunicação e mobilização social referentes à área de vigilância em saúde e imunizações, sendo responsabilidade do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador propor e desenvolver metodologias e instrumentos de análise e comunicação de risco em vigilância ambiental. Já ao Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA) cabe estabelecer estratégias de comunicação de risco e de engajamento comunitário para as emergências em saúde pública; gerir o sistema de informação de eventos de saúde pública e sua integração com os demais sistemas de informações nacionais; apoiar estudos e pesquisas que visem ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento científico e tecnológico para preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública.

Atualizações sobre vacinas e estratégias de imunização continuam sendo divulgadas por meio de Notas e Informes Técnicos no sítio oficial do MS. Em 27.02.2023, um novo Informe Técnico Operacional de Vacinação Contra a Covid-19 foi publicado, estabelecendo diretrizes e orientações técnicas para a organização da vacinação em 2023. As principais recomendações incluíam o uso de vacinas bivalentes para grupos de maior risco, a promoção da vacinação infantil e a imunização da população elegível com as vacinas disponíveis.

Os dados relacionados à situação epidemiológica da Covid-19 continuam a ser atualizados e publicados nos painéis do MS, quais sejam: Painel Coronavírus[5] e Painel Covid-19 no Brasil[6]. De forma semelhante, as bases de dados anonimizadas de Síndrome Gripal por Covid-19 (e-sus Notifica) e Srag (SIVEP-Gripe) continuam sendo atualizadas e disponibilizadas no portal de dados abertos OpenDataSUS[7], permitindo acesso aos óbitos e casos notificados em território nacional. Porém, no início do ano, decidiu-se pela mudança da periodicidade de divulgação dos dados sobre casos e óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil, que passaram a ser atualizados semanalmente a partir de 07.03.2023, e não mais diariamente.

O MS ainda mantém endereços eletrônicos de acesso público com os dados de distribuição de vacinas contra Covid-19 a Estados e Municípios, obtidos do Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (Sies), utilizado pela SVSA e pelos entes subnacionais, entre outros, para

[5] Disponível em: https://covid.saude.gov.br

[6] Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

[7] Disponível em: https://opendatasus.saude.gov.br

gerenciar seus estoques de vacinas e o quantitativo de doses aplicadas, obtido do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).

Em 2023, também foi retomada a publicação dos informes epidemiológicos da vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios, incorporando as análises epidemiológicas da Covid-19, sendo renomeada para Informe Epidemiológico das Síndromes Gripais[8].

Por fim, destaca-se que, em 24.10.2023, o Governo Federal lançou o programa Saúde com Ciência, uma iniciativa inédita em defesa da vacinação e voltada ao enfrentamento da desinformação. A proposta faz parte da estratégia para recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil, considerando que a propagação de *fakenews* é um dos fatores que impacta na adesão da população às campanhas de imunização.

A estratégia interministerial é coordenada pelo MS e pela Secretária de Comunicação Social da Presidência da República, com a parceria dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Ciência e Tecnologia e Inovação, e com a CGU e AGU.

Com o objetivo de fortalecer as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico, o Saúde com Ciência é composto por cinco pilares, que envolvem cooperação, comunicação estratégica, capacitação, análises e responsabilização. O programa prevê ainda ações para identificar e compreender o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder aos efeitos negativos das redes de desinformação em saúde de maneira preventiva.

Assim, a partir do acompanhamento e análise de fontes de dados relevantes de disseminação de informações falsas no ambiente digital, a meta é desenvolver ações para reduzir e mitigar o efeito negativo desses conteúdos que prejudicam a confiança da população na segurança das vacinas e que impactaram significativamente nas ações promovidas pelo PNI nos últimos anos. Alertas e análises sobre desinformações identificadas serão publicados no portal do Saúde com Ciência, redes sociais do Governo Federal e em plataformas de mensagens, como WhatsApp. Pelo www.gov.br/saudecomciencia, a população brasileira terá disponível informações confiáveis sobre vacinação e as *fakenew*s que circulam na internet.

Será possível também, por meio de um formulário, enviar informações duvidosas para que a equipe do MS possa responder em seus canais. O *site* traz ainda um passo a passo sobre como cada um pode denunciar, nos canais oficiais das plataformas digitais, os conteúdos enganosos, contribuindo para reduzir a sua disseminação na internet.

Em sua manifestação de agosto de 2025, o MS destacou um vácuo importante na comunicação, transparência e participação social durante emergências em saúde pública, marcado por descontinuidade das estratégias de comunicação, baixa integração entre os entes federativos e fragilidades na coordenação das mensagens públicas, o que prejudicou a confiança da população e a adesão às medidas sanitárias.

[8] Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus/atualizacao-de-casos

Como resposta, o MS informa que, a partir de 2023, incorporou a comunicação como eixo estruturante das ações do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA) e do Centro de Operações de Emergências (COE). Entre as medidas, destaca-se a previsão, em todos os COE e Salas de situação contarem com a participação das três esferas de governo.

Além disso, o MS menciona que o DEMSP tem incentivado estados e municípios a se articularem com as instâncias locais de controle social por meio de capacitações, oficinas e materiais técnicos, além de atuar na construção de estratégias de base comunitária, visando fortalecer a notificação precoce de eventos e o engajamento nas ações de enfrentamento. Destacou ainda a atuação da equipe técnica de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário do DEMSP como responsável pela produção de guias e manuais, promoção de treinamentos para públicos prioritários, suporte técnico ao COE e no combate à desinformação.

Podemos apontar as seguintes causas para os problemas de comunicação, participação e transparência observados durante a pandemia do Covid-19: ausência de uma política institucionalizada para coordenação da comunicação em saúde para enfrentamento às ESP; a pandemia de Covid-19 exigiu respostas rápidas e eficazes, em cenário de incerteza, que muitas vezes tiveram que ser definidas conforme o conhecimento sobre o vírus evoluía; acesso desigual à informação, o que pode dificultar a implementação de medidas preventivas e a busca por assistência médica quando necessária; a dificuldade de transmitir informações científicas de forma inteligível ao público; e resistência à mudança de comportamento, dada a necessidade de convencer a população a adotar medidas preventivas, como o distanciamento social e o uso de máscaras, agravada com a disseminação de notícias falsas.

A falta de coordenação da comunicação em saúde frente ao grande volume de informações, muitas vezes contraditórias, sobre a Espin, trouxe uma série de consequência, tais quais: entraves à disseminação de mensagens claras e precisas, prejudicando a tomada de decisão baseada em evidências científicas, gerando medo e confusão na população; perda de credibilidade nas informações fornecidas, o que comprometeu uma das bases de sustentação institucional da autoridade sanitária, essencial para a gestão eficaz da saúde pública e, sobretudo, da resposta à Espin, prejudicando os esforços de vacinação e adesão às medidas de prevenção; e a falha na comunicação de riscos e medidas preventivas, juntamente com a disseminação de desinformação, contribuiu para agravamento dos riscos de contaminação e, consequentemente, para a sobrecarga do sistema de saúde e incremento de óbitos.

Conclui-se que a comunicação em saúde deve desempenhar papel fundamental na disseminação de informações confiáveis, na promoção de comportamentos saudáveis e na mobilização da comunidade, contribuindo, assim, para a tomada de decisões informadas durante uma ESP. A ausência de diretriz estratégica bem comunicada e transparente afeta, em última instância, o cotidiano dos cidadãos brasileiros, pois, nesse contexto, não fica claro o que é esperado da população.

7. Desafios na governança e interoperabilidade dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em Saúde.

A publicidade, princípio do art. 37 da CF/1988, foi reforçada pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), que fixou a publicidade como regra e o sigilo como exceção, destacando o controle social, o uso de tecnologias da informação e a cultura de transparência. O Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a LAI, instituiu a transparência ativa, impondo aos órgãos o dever de divulgar, independentemente de solicitação, informações de interesse público. No mesmo sentido, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) prevê governança multiparticipativa, interoperabilidade entre sistemas e serviços digitais integrados e simplificados.

A Política de Dados Abertos do Executivo federal, criada pelo Decreto nº 8.777/2016, busca fomentar a cultura de transparência, o controle social e a interoperabilidade de sistemas, reafirmando o princípio da publicidade das bases de dados. Já o Decreto nº 9.203/2017 consolidou a transparência como princípio de governança pública, vinculando-a à comunicação aberta, ao foco em resultados e à busca de soluções inovadoras. Em complemento, a Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital) estabeleceu como princípios a transparência, o monitoramento da qualidade dos serviços, a participação social, a interoperabilidade e a promoção de dados abertos.

No campo da saúde, a Portaria GM/MS nº 1.434/2020 instituiu a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) como plataforma nacional para integração e interoperabilidade de informações em saúde entre entes federativos, serviços públicos e privados. Em 2020, todas as unidades federativas já estavam conectadas por meio do Conecte SUS e APIs. A Portaria GM/MS nº 3.632/2020 instituiu a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28), estruturada em Plano de Ação e Plano de Monitoramento e Avaliação, com o objetivo de consolidar a RNDS como plataforma digital de inovação e informação em saúde até 2028. A ESD28 prevê modelo de governança pelo Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD), sob liderança do MS e com participação colaborativa de atores externos.

Nesse contexto, o DataSUS, vinculado à Secretaria Executiva do MS, tem a missão de implementar a RNDS e garantir a integração dos sistemas de informação do SUS. Já a Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI/MS), reorganizada pelo Decreto nº 11.798/2023, exerce papel central na coordenação da Saúde Digital, cabendo ao Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMAS) da SEIDIGI coordenar a Política de Dados Abertos, integrar monitoramento e avaliação e disseminar informações estratégicas para a tomada de decisão.

7.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

O DataSUS relatou que, diante da decretação do estado de calamidade em 2020, o Conecte SUS tornou-se eixo prioritário para apoiar a gestão da crise. Em paralelo, a SEIDIGI mobilizou núcleos de Telessaúde para atuação integrada em tele-orientação, telemonitoramento, telediagnóstico, teleconsultoria e tele-educação, ampliando a assistência tanto à população quanto aos profissionais do SUS. Já o DEMAS informou a adoção de medidas de transparência

digital, como o Portal LocalizaSUS e o Portal de Dados Abertos, que passaram a disponibilizar informações diárias sobre vacinação, adoecimento e mortalidade.

Segundo a Abrasco (2022), os sistemas centrais de informação durante a pandemia foram:

- e-SUS VE (notificação de casos de síndrome gripal suspeitos/confirmados de Covid-19);
- SIVEP-Gripe (monitoramento de Síndrome Respiratória Aguda Grave, atualizado para incluir Covid-19 com hospitalização ou óbito);
- SI-PNI (dados individualizados de imunização, integrado à RNDS);
- VigiVvac (base para análise da efetividade vacinal, em parceria com a Fiocruz); e
- Sistemas complementares como SIM, SINASC, SIH, CNES, além de PNAD Covid-19 e relatórios de mobilidade do Google.

Apesar dessa multiplicidade, o Conasems apontou que a fragmentação de mais de 400 sistemas do MS prejudicou a integração e o uso estratégico da informação. Houve falhas na notificação, atrasos na manutenção dos sistemas e sobreposição de soluções temporárias, dificultando o planejamento local e regional.

As falhas impactaram principalmente a vacinação: incongruências entre microdados e painéis, duplicidades e priorização de números absolutos que distorciam desigualdades regionais e sociais. A Abrasco destacou dois momentos críticos: a suspensão da divulgação de dados acumulados em junho de 2020, no auge da primeira onda, e o "apagão de dados" em dezembro de 2021, quando sistemas do MS ficaram indisponíveis por ataque cibernético, justamente durante o avanço da variante Ômicron.

Tentativas de aperfeiçoamento incluíram a Portaria GM/MS nº 2.236/2021, que instituiu o Conecte SUS Cidadão, possibilitando emissão digital do Certificado Nacional de Vacinação e acesso a informações detalhadas de doses aplicadas. Contudo, persistiram problemas de interoperabilidade entre sistemas (e-SUS APS, SI-PNI, SIASI), limitando a confiabilidade dos registros.

O TCU, em diversos acórdãos, reforçou as deficiências:

- Acórdão nº 2.878/2021 – identificou discrepância de 9,2 milhões de doses entre sistemas do MS;
- Acórdão nº 2.622/2022 – relatou atrasos e inconsistências na integração SI-PNI/e-SUS APS;
- Acórdão nº 2.369/2022 – apontou ausência de registros consistentes sobre morbidade e mortalidade pós-Covid; e
- Acórdão nº 1.888/2020 – já havia alertado para a necessidade de transparência tempestiva e padronização das informações.

Diante desse cenário, a Corte de Contas recomendou ao MS adotar medidas estruturantes para:

1. Aprimorar a integração de sistemas de vigilância (especialmente SI-PNI, e-SUS APS e SIASI);

2. Incluir variáveis adicionais em fichas de notificação de SRAG (uso de medicamentos, doses adicionais de vacina, imunização contra influenza);
3. Padronizar registros e boletins epidemiológicos, garantindo consistência entre bases e painéis; e
4. Publicar dados pós-Covid sobre morbidade e mortalidade, subsidiando apoio técnico e financeiro aos entes federados.

Em síntese, embora a pandemia tenha acelerado a digitalização em saúde (Conecte SUS, telessaúde, painéis interativos), expôs falhas críticas de governança, interoperabilidade e confiabilidade dos dados. As análises da Abrasco, Conasems e TCU convergem para a necessidade de uma política pública de Estado permanente para dados em saúde, capaz de assegurar integração, transparência e uso estratégico das informações em futuras emergências sanitárias.

7.2 Situação atual

Segundo o DataSUS, a RNDS viabilizou o compartilhamento seguro de mais de 72 milhões de exames de Covid-19, integrando dados de 337 sistemas privados e 3 públicos (GAL, e-SUS Notifica e e-SUS APS). O Meu SUS Digital (antigo Conecte SUS) reúne mais de 1,1 bilhão de registros de vacinas e outros dados clínicos, consolidando-se como fonte nacional de imunização. A pandemia também acelerou a adoção de padrões de interoperabilidade, como os códigos LOINC, e a integração de laboratórios privados à RNDS, além de aplicativos como o Coronavírus SUS e e-SUS Notifica, o que representou marcos relevantes para a saúde digital no País.

Porém, o Conasems destacou, em Ofício encaminhado a esta equipe, a necessidade de investimento contínuo e sustentável em sistemas de vigilância, ressaltando que, mesmo após o fim da emergência de Covid-19 pela OMS em maio de 2023, o SINAN não foi atualizado e as notificações seguem em sistemas paralelos — inclusive para doenças como a *Monkeypox* — o que, embora funcional, gera sobrecarga e dificulta a governabilidade local; tais problemas poderiam ser mitigados com investimentos do Ministério da Saúde que permitam aos municípios focar no atendimento da população em vez de operar múltiplos sistemas.

Pode-se apontar as seguintes causas para os problemas encontrados nos sistemas de informação em saúde durante a pandemia: apesar da criação da ESD28 visando a integração de dados em saúde, a sua implementação enfrentou obstáculos como a falta de interoperabilidade entre os sistemas existentes, como e-SUS VE, SIVEP-Gripe e SI-PNI, e a nova infraestrutura da RNDS, o que evidencia desafios técnico-organizacionais que se devem, em parte, à diversidade dos sistemas em uso nos níveis federal, estadual e municipal; falta de capacitação e conhecimento técnico adequado entre os profissionais de saúde e gestores de dados; a estratégia de dados abertos, apesar de promissora, enfrentou críticas pela falta de transparência e pela dificuldade em acessar informações fidedignas, o que reflete limitações tanto na qualidade dos dados disponibilizados quanto na capacidade dos sistemas de manejar e disseminar esses dados de forma eficaz; e a complexidade e a envergadura dos esforços para integrar os sistemas de saúde digital exigem liderança forte e governança efetiva, que enfrenta desafios na coordenação entre as diversas instâncias de gestão.

Como consequências para os problemas encontrados nos sistemas de informação em saúde empregados durante a pandemia, cite-se: a interoperabilidade incipiente resultou em inconsistências nos dados, especialmente no que tange à vacinação contra a Covid-19 e ao monitoramento de casos e óbitos; a falta de dados confiáveis e atualizados comprometeu o monitoramento da evolução da doença, a adequada distribuição de vacinas e a implementação de políticas de saúde pública baseadas em evidências; controle social precário: a ausência de informações transparentes e tempestivas prejudica o efetivo controle da Administração Pública pela população; e as limitações dos sistemas de vigilância em saúde e a falta de transparência nas informações contribuíram para aumentar a desconfiança da população em relação às medidas adotadas pelo governo para enfrentamento da pandemia.

Entende-se que a ESD28 desempenhou um papel importante no aproveitamento de tecnologias e estratégias de saúde digital para enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, promovendo o compartilhamento de informações, a telemedicina e a integração de ferramentas digitais para avaliação e monitoramento de pacientes, concretizada pela RNDS.

Ainda assim, a interoperabilidade dos sistemas de informação institucionalizados para auxílio de emergências em saúde ainda é incipiente, apresentando baixa qualidade de dados (inconsistências), o que, em última análise, resulta em informações pouco transparentes e intempestivas, enfraquecendo o controle social e a tomada de decisões baseada em evidências, na medida em que as informações não se mostram inteligíveis para o público em geral e tampouco apoiam o planejamento de ações prioritárias.

Em manifestação de 2025, o MS reconheceu a fragmentação dos sistemas de informação durante a pandemia e afirmou estar investindo desde 2023 em soluções interoperáveis e transparentes, com atualização de plataformas, novos painéis de monitoramento e integração de dados epidemiológicos, assistenciais e logísticos em tempo real (Sala de Situação Nacional e Sistemas de Comando de Incidentes).

Conclui-se ser premente a institucionalização de uma política pública de Estado para enfrentamento das ESP, com foco na modernização, integração e governança dos sistemas de informação em saúde, assegurando transparência, tempestividade e apoio efetivo à gestão do cuidado.

8. O Planejamento de contingências apresenta limitações e carece de institucionalização.

O objetivo do presente tópico é avaliar a situação de institucionalização do planejamento de contingências no âmbito da resposta às ESP e se há normas que estabeleçam um padrão para a elaboração de planos de contingências de âmbito nacional pelo MS, alinhados com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e com a gestão de riscos. Ademais, também se pretende elucidar se existem normas, planos ou projetos que estabeleçam o fomento, apoio e/ou orientação técnica do MS aos estados e municípios na elaboração de planos de contingência, alinhados com o plano nacional e com a gestão de riscos.

O MS define Planos de Contingência (PC) como um documento que registra o planejamento elaborado a partir do estudo de uma determinada hipótese de emergência em saúde pública. A SVSA definiu como prioritários os Planos de Contingência para dengue, febre amarela, influenza, hantavirose, leishmaniose visceral e manejo de desastres (inundação e seca).

O PC é um pré-planejamento para possíveis eventos, e serve de subsídio para a elaboração do Plano de Ação do Evento (PAE). No PC estarão previstas as responsabilidades de cada organização, as prioridades e medidas iniciais a serem tomadas e a forma como os recursos serão empregados para uma determinada tipologia de emergência em saúde pública.

A normatização de ações e planos de emergência em saúde pública é um meio de institucionalização e coordenação, de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica de atores na área da saúde, que devem ser coordenadas com o fim de alcançar seus objetivos, evitando assim superposições ou esforços mutuamente contraproducentes (BRASIL, 2014b). A lei 8.080/90 designa à direção nacional do SUS a competência de coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica[9].

Por sua vez, a PNVS estabelece que a resposta às emergências em saúde pública deve estar contemplada nas estratégias para Vigilância em Saúde, com a formulação de plano de resposta, a ser elaborado em cada esfera de gestão, atribuindo à União, por meio da SVSA e Anvisa a função de coordenar, em âmbito nacional as ações de vigilância em saúde e a cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios.

Cite-se também a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)[10] que define plano de contingência como o "conjunto de procedimentos e de ações previsto para prevenir acidente ou desastre específico ou para atender emergência dele decorrente, incluída a definição dos recursos humanos e materiais para prevenção, preparação, resposta e recuperação, elaborado com base em hipóteses de acidente ou desastre, com o objetivo de reduzir o risco de sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos".

Adicionalmente, a Lei que instituiu a PNPDEC estabelece formalmente as regras, critérios objetivos e os elementos mínimos que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil deverá conter. Esta contém:

a) Identificação de riscos de desastres, segundo regiões geográficas;
b) Os critérios e as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil em âmbito nacional e regional;
c) Critérios para classificação de riscos;
d) Prazos para elaboração e revisão;
e) Submissão dos planos a avaliação e a prestação de contas anual, com a participação social, prevendo inclusive audiência pública com ampla divulgação; e
f) Critérios para atualização: a cada 3 (três) anos, mediante processo de mobilização e participação social, incluída a realização de audiências e consultas públicas.

[9] Lei 8080/90, Art. 16. À direção nacional do SUS compete: VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
[10] Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.

8.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

O documento norteador vigente para resposta às ESP era o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública (2014), que definia responsabilidades, protocolos e a atuação do COE. Após a ativação do COE-nCoV (06.02.2020), o MS reuniu secretários estaduais e municipais de saúde, solicitando atualização dos Planos de Contingência (PC) e publicou o Plano de Contingência Nacional.

O TCU (Acórdão nº 1.888/2020 – Plenário) apontou que o documento se tratava de guia conceitual, sem detalhamento tático-operacional. Assim, determinou ao MS a elaboração de planos com prazos, responsáveis, custos e atividades. Entre as ações previstas estavam: integração entre vigilância e assistência, monitoramento de insumos, logística de medicamentos, ampliação de leitos e comunicação pública. Entretanto, o TCU e o CNS constataram a ausência de um Plano Nacional de Enfrentamento da Pandemia articulado com os entes federados.

Diversas determinações foram expedidas pelo TCU, relacionadas à:

- Comunicação: plano claro de informação, combate a *fake news* e medidas de prevenção;
- Assistência farmacêutica: plano detalhado com entes subnacionais;
- Orçamento: previsão de despesas (leitos, insumos, profissionais);
- Insumos estratégicos: plano para monitorar oxigênio medicinal;
- Vacinação: pactuação de plano de recuperação das coberturas vacinais;
- Medidas não terapêuticas: critérios objetivos para quarentena (Lei nº 13.979/2020); e
- Encerramento da Espin: normas sobre continuidade de ações essenciais.

O CNS ressaltou falhas na coordenação nacional e ausência de protagonismo federal. O Conasems defendeu que planos deveriam incluir capacitação técnica, não apenas burocracia. Já o Conass se opôs a notas do MS que recomendavam tratamento sem respaldo científico, e enfatizou a necessidade de ações pactuadas e baseadas em evidências.

Estados e DF adotaram medidas próprias desde março de 2020, gerando heterogeneidade nas respostas. O Conass (2023) qualificou a atuação federal como de “distanciamento da coordenação federativa”, forçando a cooperação horizontal entre governos subnacionais.

Por fim, o TCU apontou que o Plano Nacional não previa critérios uniformes para medidas restritivas. Exemplos como a quarentena em Manaus (jan/2021) revelaram a ausência de diretrizes nacionais, resultando em decisões descoordenadas.

Em síntese, as informações supracitadas apontam falhas estruturais no planejamento federal, ausência de alinhamento interfederativo e baixa aderência a princípios de governança.

8.2 Situação atual

Questionado acerca dos planos de contingência de âmbito nacional, o MS informou que “o Departamento de Emergências em Saúde Pública considera fundamental a elaboração de

orientações para produção dos Planos de Contingência em esfera local, estadual e municipal, visando padronizar os planos de contingência elaborados no país, alinhados com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI-2005) e que atualmente, as orientações para elaboração estão disponíveis no Plano de Resposta as Emergências em Saúde Pública, considerado "Plano Mestre"".

Embora o MS considere o PRESP o documento mestre para a orientação do planejamento da resposta às ESP, não restou evidenciado que tal documento esteja jurídica e oficialmente formalizado mediante norma, sequer esse atende aos critérios de avaliação adotados. O que se tem é um documento de referência, cuja última atualização ocorreu em 2014, o qual carece de atributos essenciais, que serão apontados adiante.

Ademais, o PRESP, com as características atuais, está sujeito a interpretação e implementação dependente das injunções político-governamentais, o que aumenta o risco de repetição em futuras ESP de falhas graves constatadas na resposta governamental à pandemia de Covid-19, inclusive omissões, a exemplo do que se deu com o planejamento de medidas não terapêuticas. Acerca disso, o MS informou, por meio da Nota Técnica nº 9/2025-DEMSP/SVSA/MS que está em desenvolvimento o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública revisado.

A partir das informações constantes nos tópicos situação ocorrida e situação atual, além da análise do PRESP/MS – enquanto padrão para elaboração dos planos de contingência, do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 e outros documentos de planejamento do MS, constatam-se as seguintes lacunas na institucionalização do planejamento da resposta às Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional e/ou Internacional:

a) Institucionalização formal: não há a institucionalização formal de regras, critérios objetivos e elementos mínimos para um plano nacional e planos regionais e locais de resposta às ESP, em contraste com a PNPDEC, que além de ser formalmente instituída mediante Lei, estabelece critérios objetivos e diversos elementos essenciais a um plano de contingência nacional;

b) Elaboração, revisão e lições aprendidas: não se estabelecem prazos para elaboração nem a periodicidade para revisão do plano nacional. Inclusive, o PRESP/MS é de 2014 e desde então não foi identificada versão mais atual publicada, não obstante haver muitas lições a serem aprendidas a partir de experiências com ESP anteriores, em especial a pandemia de Covid-19;

c) Participação: não há previsão expressa de ampla participação das partes interessadas nas atividades de planejamento. Em especial, não há a institucionalização da participação social na elaboração, avaliação e revisão dos planos, a exemplo de audiências e consultas públicas;

d) Diretrizes e critérios: não há a institucionalização formal de critérios objetivos e de diretrizes de ação governamental para resposta às ESP em âmbito nacional e regional;

e) Avaliação de riscos e vulnerabilidades: Não há identificação de riscos de ESP segundo regiões geográficas e diferentes grupos populacionais, excetuando os planos de contingência para povos indígenas;

f) Decisão baseada em evidências e princípios da precaução e da prevenção: a institucionalização existente não contempla o processo decisório nem a formulação de políticas baseados em evidências, nem a adoção dos princípios da prevenção e da precaução (ver discussão detalhada sobre o assunto, no ponto sobre processo decisório), sequer o aproveitamento da experiência de outros países e de regiões, observadas as variações regionais. Sobre isso, o PRESP/MS define protocolo como um processo de decisão discutido e acordado antes de uma crise, mas não estabelece ampla participação das partes interessadas na definição dos protocolos, nem os princípios da precaução e da prevenção, assim como o processo decisório baseado em evidências;

g) Integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico do Ministério da Saúde: os critérios estabelecidos no Art. 17, I a IV, do Decreto nº 9.203/2017, não são atendidos. No tocante ao planejamento da resposta às ESP, não se evidenciou a integração da gestão de riscos ao Plano Estratégico Institucional do MS. Inclusive, o acórdão nº 2.463/2022 do TCU registra a inexistência tempestiva de um Plano Estratégico Institucional, informando que apenas em 15.06.2022 – e, portanto, apenas após a declaração do final da pandemia de Covid-19 – a sua equipe de auditoria recebeu um e-mail da Secretaria Executiva com o novo Plano Estratégico Institucional (PNS 2020-2023), aprovado pelo CIG, em sua 3ª Reunião Ordinária realizada em 27.05.2022;

h) Avaliação e prestação de contas: não há previsão de submissão dos planos a avaliação e a prestação de contas anual, com a participação social, prevendo inclusive audiência pública com ampla divulgação. Exceção é a previsão de realização da oficina de lições aprendidas, à qual se aplicam as ressalvas tratadas no último ponto do relatório;

i) Critérios para atualização: não são estabelecidos critérios para atualização, inclusive periodicidade, sequer processo de mobilização e participação social, incluída a realização de audiências e consultas públicas;

j) Suficiência do planejamento: conforme apontou o TCU, o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus Covid-19 (que se supõe elaborado segundo o PRESP/MS) difere de um plano de ação e não supre a necessidade de planos táticos-operacionais ou planos de ação, não evidenciados. Como dito, é necessário o estabelecimento de prioridades, objetivos e metas, coerentes entre si e com o delineamento estratégico mais amplo ao qual os planos se integram. Logo, os planos devem permitir a operacionalização das ações necessárias, delineados em função das diretrizes, objetivos e metas propostas; e

k) Visão de futuro: O PRESP/MS é de natureza geral e referencial, assim como tem foco em determinado evento. Tanto esse quanto os planos de contingência específicos para resposta às ESP carecem do estabelecimento de critérios relativos a uma visão de futuro, notadamente quanto à redução de vulnerabilidades e promoção de resiliência e de capacidades, o que é essencial para a prevenção e preparação frente a futuras ESP.

Quanto à previsão institucional de apoio a Estados e Municípios, não foram identificadas normas que estabeleçam o fomento, apoio e/ou orientação técnica do Ministério da Saúde aos estados e municípios na elaboração de planos de contingência, alinhados com o plano nacional e com a gestão de riscos, embora o MS tenha realizado interações com os entes federado, com o fim de promover a elaboração de planos de contingência no início da pandemia de Covid-19, ao que se aplicam as ressalvas discutidas anteriormente, bem como em 2024 o lançamento do Guia para Elaboração de Planos de Contingência pelo DEMSP/SVSA/MS, que fornece orientações padronizadas aos diferentes cenários de risco no âmbito da saúde.

Para mitigar a situação atual de institucionalização de resposta às ESP que favorece o risco de que os planos de cada emergência e respectivos planos dos Estados e Municípios sejam elaborados sem alinhamento entre si e com um plano nacional, o que de fato ocorreu na resposta governamental à Pandemia de Covid-19, dada a descoordenação constatada, conforme tratado em outros pontos do relatório, o MS tem também incentivado a análise, aperfeiçoamento e atualização dos planos de contingência por meio de Oficinas de Avaliação dos Planos que vêm sendo realizadas em conjunto com as Oficinas de Simulados.

Do achado decorrem várias consequências, dentre as quais são ressaltadas as seguintes: atuação reativa e não aquela orientada para priorizar a prevenção, redução de vulnerabilidades e promoção das capacidades do sistema de saúde e do país; ambiente não favorável à articulação horizontal e transversal no âmbito do SUS; falta de ação decisória e/ou de gestão e operacional; medidas descoordenadas e falta de cooperação entre as partes interessadas; e favorecimento de um ambiente de dúvidas e incertezas junto à população.

Conclui-se, ante o exposto, que não há normas formalmente instituídas, segundo os critérios de análise, incluindo princípios e boas práticas de governança, que estabeleçam adequadamente as bases para o planejamento da resposta às ESP e para a elaboração de planos de contingências de âmbito nacional pelo MS, alinhados com o Regulamento Sanitário Internacional, com o referencial da OMS baseado em riscos para gestão de emergências em saúde e desastres, sequer com a gestão de riscos estabelecida no Decreto nº 9.203/2017.

9. O planejamento do MS passou a contemplar indicadores e metas que visam à promoção de resiliência frente às ESP.

O presente tópico objetiva avaliar se os planos, metas e indicadores no âmbito do Ministério da Saúde estabelecem enquanto objetivo a redução de vulnerabilidades e a promoção de resiliência de populações, de territórios e/ou do SUS frente às ESP.

O Decreto nº 9.203/2017 estabelece como mecanismo para o exercício da governança pública a estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido.

O TCU menciona a necessidade que uma política pública possui de ter planos que permitam operacionalizar as ações necessárias, delineados em função das diretrizes, objetivos e metas propostas, tendo como boas práticas a visão estratégica de longo prazo (BRASIL, 2014b). Na mesma linha, o guia ex-ante da CGU menciona que políticas públicas devem ter planos que estabeleçam *mudanças de mais longo prazo promovidas sobre o aspecto ou a perspectiva futura de seus beneficiários ou grupo no qual se inserem*[11].

Ademais, o referencial do TCU estipula que a elaboração de planejamento seja flexível e contínua, considerando que mudanças são inevitáveis durante a implantação para se ajustar a diferentes circunstâncias, novas informações, ou achados dos processos de avaliação e monitoramento (BRASIL, 2014b).

9.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

O planejamento na Administração Pública Federal (APF) organiza-se em três níveis: (i) planos orçamentários – PPA, LDO e LOA; (ii) planos setoriais da saúde – Plano Nacional de Saúde (PNS) e Programação Anual de Saúde (PAS); e (iii) planos internos das entidades – como o Planejamento Estratégico Institucional (PEI).

O PPA 2020–2023 (art. 3º, XI) estabeleceu a diretriz de ampliar a cobertura e a resolutividade da atenção primária, com prioridade na prevenção e integração dos serviços. A ele se vinculam todos os programas do MS, incluindo a Vigilância em Saúde (Programa 5023), cujo objetivo é reduzir ou controlar doenças e agravos, tendo como meta a aquisição e distribuição de 100% dos imunobiológicos de responsabilidade do MS (Anexo I do PPA).

Já o PNS, previsto na Lei nº 8.080/1990 e no § 4º do art. 165 da Constituição Federal, é elaborado para quatro anos e orienta o planejamento do SUS, refletindo as necessidades de saúde da população (MS, 2020). O PAS detalha anualmente o PNS, em relação análoga à LOA perante o PPA. Já o PEI, previsto no art. 22 da Lei nº 13.971/2019 e regulamentado pela IN ME/SE nº 24/2020, consolida a estratégia interna do MS.

Quanto ao PEI 2020–2023, vigente durante a pandemia, não foi instituído nos prazos previstos, sendo publicado apenas em 2022, em descumprimento ao PPA e à IN ME/SE nº 24/2020. Segundo o Acórdão TCU nº 2463/2022, a ausência do PEI foi reiteradamente comunicada ao MS por e-mails e reuniões com o Datasus, gabinete do Ministro e Secretaria Executiva.

Na sua versão final, o PEI 2020–2023 apresentou 48 indicadores distribuídos em 21 objetivos estratégicos, com áreas responsáveis por seu acompanhamento. Destes, oito ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVSA), unidade encarregada da coordenação da vigilância em saúde e da preparação e resposta às emergências de saúde pública no âmbito nacional e internacional, em articulação com estados, DF e municípios.

O MS informou ainda que, no âmbito das emergências em saúde pública (ESP), dispunha apenas do Indicador 08.02, relativo ao percentual de CIEVS com capacidade satisfatória de

[11] Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante, volume 1.

monitoramento, alerta e resposta, incorporado ao PPA e ao PNS. Dos quatro objetivos estratégicos e oito indicadores da SVSA, somente o Objetivo 08 (Intensificar ações de vigilância em saúde) envolve as ESP, sendo o Indicador 08.02 de responsabilidade do DEMSP, unidade encarregada do enfrentamento das emergências nacionais e internacionais.

O Ministério também destacou a elaboração do Caderno Especial de Indicadores sobre a Covid-19 (RIPSA), voltado ao monitoramento durante a pandemia. Embora relevante para a fase de recuperação, a medida não envolve ações de prevenção, mitigação e preparação, como preconiza a OMS (EDRM), que propõe uma abordagem proativa baseada em riscos e vulnerabilidades.

Constata-se que a utilização de apenas um indicador não atende ao modelo de gestão previsto no Decreto nº 9.203/2017 (art. 5º, II) e não foi acompanhada de atualização no PEI 2020–2023 nem no PNS 2020–2023. A ausência de revisão e a limitação de indicadores contrariaram as boas práticas de planejamento contínuo e flexível do TCU (BRASIL, 2014b).

9.2 Situação atual

Em resposta aos questionamentos sobre a situação atual do Planejamento acerca das capacidades para enfrentamento as ESP, o MS informou[12] que expressou como meta no Plano Plurianual (PPA) e na Política Nacional de Saúde (PNS) para o período de 2024–2027 — "Ampliar a capacidade de enfrentamento às emergências em saúde pública por meio de ações de preparação, vigilância e resposta nas 27 Unidades da Federação". Tendo como indicador o "percentual de conclusão da estratégia de fortalecimento das capacidades das Unidades Federativas no enfrentamento de futuras emergências em saúde pública".

Na mesma direção está o PEI 2024-2027, que prevê como Objetivo Geral 08, "Ampliar e qualificar a capacidade de enfrentamento às emergências e desastres", e como objetivo específico, "fortalecer as capacidades de preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública (ESP) nos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o enfrentamento eficaz das ameaças à saúde pública".

As atualizações trazidas pelo MS no seu Planejamento estão na direção do que se espera para a mensuração de resultados de longo prazo, em especial os que visam à redução de vulnerabilidades e promoção de resiliência durante a pandemia: adoção de um planejamento flexível e contínuo que aborda elementos estratégicos específicos de ESP, com foco nas vulnerabilidades e capacidades e com postura proativa frente a futuras ameaças; publicação em tempo adequado do Planejamento Estratégico Institucional 2024-2027; e definição de Objetivos Estratégicos específicos para as ESP, dada sua relevância, conforme constatado no contexto da Covid-19 no país, além do fortalecimento de estratégias de prevenção e promoção de resiliência.

Conclui-se que a presença de objetivos estratégicos, metas e indicadores de saúde específicos apresentados atualmente pelo MS caminham em direção ao fortalecimento da avaliação e o

[12] Resposta à Solicitação de Auditoria nº 09, em 12.08.2025.

monitoramento do progresso da saúde em geral, inclusive em regiões que historicamente têm apresentado os piores resultados em saúde.

10. Dependência tecnológica a insumos estratégicos: necessidade de institucionalização integrada em uma política de Estado no enfrentamento às ESP.

O presente tópico visa avaliar se existem normas, planos ou projetos que estabeleçam o fomento à inovação e desenvolvimento de vacinas e outros insumos estratégicos com o objetivo de reduzir a dependência do país, integrados à resposta às Emergências em Saúde Pública, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade do país às ESP.

A Constituição Federal atribui ao SUS a competência de incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação[13]. A lei nº 8.080, de 19.09.1990, por sua vez, reproduz o mesmo texto, trazendo relevância ao desenvolvimento científico e tecnológico na saúde pública.[14] Além disso, a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) também determina responsabilidade da União, por meio da SVSA e a Anvisa, de promover e realizar estudos, pesquisas e avaliação de tecnologias na área de vigilância em saúde.[15]

Destaca-se, também, como critério, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), que possui entre as suas estratégias a de sustentação e fortalecimento do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação em saúde. Sobre essa estratégia, a PNCTIS dispõe:

> 63. As principais ações dessa estratégia são:
> a) articulação com os órgãos responsáveis pela formação de novos pesquisadores e apoio à iniciação científica em todos os níveis de ensino, bem como nos pólos de educação permanente em saúde, respeitando as necessidades regionais e criando canais de participação para os novos pesquisadores;
> [...]
> c) criação, ampliação, diversificação e garantia de continuidade das fontes de financiamento para ações de P&D em saúde;

A PNCTIS é implementada pelo Fomento Nacional, que é uma estratégia realizada pelo MS, no âmbito da SCTIE, especialmente no que concerne o fortalecimento nacional em CT&I/S.

---

[13] CF, Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

[14] Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;

[15] RESOLUÇÃO Nº 588, DE 12 DE JULHO DE 2018. Art. 11 São responsabilidades da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a gestão da vigilância em saúde no âmbito da União, compreendendo: XVI – promover e realizar estudos, pesquisas e avaliação de tecnologias que contribuam para o aperfeiçoamento das ações e incorporação de inovações na área de vigilância em saúde.

Um outro critério a considerar, no tocante aos temas correlatos às respostas às emergências nacionais, é a PNPDEC - Lei nº 12.608/2012, que estabelece as seguintes competências para a União, em seu Artigo 6º, no tocante à redução de vulnerabilidades e fomento à pesquisa:

> XI - incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e a distância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil;
> XII - fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres.

10.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

Durante a pandemia de Covid-19 exteriorizou-se a dependência tecnológica, riscos e gargalos produtivos que recaem sobre a imunização no país, não havendo alternativas suficientes aos altos preços, prazos dilatados e condições desfavoráveis prevalentes em tempos de crise ou escassez. Exemplificando, a ausência de produção nacional de vacinas para a Covid19 e a necessidade de aquisição de produtores do exterior trouxeram embates prévios, concomitantes e até posteriores à produção de vacina local, como possíveis fragilidades nas contratações para aquisição de imunizantes[16], momento da aquisição[17], fragilidades nos controles e na logística de distribuição[18], dificuldades no índice de cobertura vacinal[19], passaporte vacinal[20], etc.

Acerca do momento da aquisição dos imunizantes, o TCU considerou que havia justificativas plausíveis para o atraso identificado na assinatura do Contrato de Transferência de Tecnologia (CTT) para produção nacional do IFA da vacina, considerando a complexidade do processo de transferência de tecnologia e as autorizações regulatórias necessárias[21]. Contudo, houve discussão acerca de atrasos na concessão de autorizações e registros de vacinas COVID-19 por parte da ANVISA.

Observe-se que as circunstâncias anteriores foram consideradas justificáveis no contexto de então, mas seriam evitadas ou mitigadas na hipótese de o país possuir menor dependência tecnológica.

10.2 Situação atual

Ainda no ano de 2022 publicou-se a Portaria GM/MS n. º 4.282, de 12.12.2022, com o objetivo de estabelecer diretrizes para o financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de desenvolvimento ou inovação em saúde pelo MS. Esta Portaria estabeleceu que a seleção de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de desenvolvimento ou inovação em saúde deve ocorrer por meio de chamada pública ou de celebração direta, sendo que a contratação direta será aplicada a projetos que atendam a demandas em caráter de

[16] TCU, processo 015.125/2021-1
[17] Acórdão 534/2021 – TCU – Plenário
[18] TCU, processo 015.125/2021-1
[19] Acórdão 2.622/2022 – TCU – Plenário
[20] Acórdão 2.369/2022 – TCU – Plenário
[21] TCU, processo 014.575/2020-5.

emergência em saúde pública, que apresentem justificada singularidade ou, ainda, que sejam considerados prioritários para o Ministério da Saúde.

Acerca do fomento a projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de desenvolvimento ou inovação, dentre os trabalhos recentes realizados pela CGU afetos ao tema de governança, cita-se o de "Avaliação de governança no Financiamento de Estudos e Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação em Saúde", realizado no âmbito do Ciclo de 2022 do CMAP, no qual se pontuaram os seguintes achados sobre a Institucionalização: Competências das partes envolvidas no PPSUS definidas parcialmente; Ausência de institucionalização formal do Programa de Fomento Nacional; e Fragilidades na definição formal das competências das partes envolvidas no Programa de Fomento Nacional.

A citada avaliação, portanto, reforça a necessidade ainda existente de institucionalização formal dos programas no Financiamento de Estudos e Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação em Saúde, que é o tema central do atual ponto, juntamente com a integração desse com uma política pública de Estado para resposta governamental às ESP.

Informou o MS que no ano de 2023, por meio do decreto nº 11.715/23, houve o lançamento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Estratégia CEIS), sendo criados seis programas estruturantes, que visam expandir a produção nacional de itens prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros, que dentre os objetivos está o de reduzir vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso universal à saúde, por meio do desenvolvimento e da absorção de tecnologias em saúde[22].

Além disso, foram selecionados dois projetos no âmbito do Novo PAC Saúde - Subeixo CEIS que envolvem esforços para o desenvolvimento e produção de vacinas de RNA mensageiro (RNAm). Os dois projetos buscam desempenhar um papel importante no fortalecimento da capacidade de resposta do País a Emergências de Saúde Pública.

No final de 2023, o MS passou a nortear sua estratégia pela [23]Matriz de Desafios Produtivos e Tecnológicos em Saúde, que é sistematizada a partir dos desafios em saúde e soluções produtivas e tecnológicas, apresentadas na forma dos blocos, entre eles, está o de "Preparação do Sistema de Saúde para Emergências Sanitárias" (Bloco I).

A SECTICS/MS, informou também que elaborou as "Diretrizes para Fomento de Pesquisas Científicas, Tecnológicas, de Desenvolvimento e/ou Inovação em Saúde em Resposta às Emergências de Saúde Pública", estruturado em torno dos seguintes objetivos:

a) estabelecer uma atuação coordenada e articulada no âmbito da ciência e tecnologia para resposta às emergências de saúde pública, potencializando a utilização de recursos e otimizando o tempo de resposta;

[22] Decreto nº 11.715, de 26 de setembro de 2023, art. 3º São objetivos da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde: I - reduzir vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso universal à saúde, por meio do desenvolvimento e da absorção de tecnologias em saúde;
[23] Portaria GM/MS nº 2.261, de 08.12.2023

b) definir as etapas necessárias para seleção de projetos de pesquisa científica, tecnológica, de desenvolvimento e/ou inovação em saúde em resposta às emergências de saúde pública; e
c) estabelecer as estratégias para monitoramento e avaliação das pesquisas contratadas no âmbito das emergências de saúde pública; e propor mecanismos para a disseminação dos resultados das pesquisas fomentadas, de forma rápida e qualificada, de maneira a subsidiar as respostas em emergências de saúde pública com base em evidências científicas.

O documento revela potencial para integrar a institucionalização do fomento à inovação, o desenvolvimento de vacinas e a produção de insumos estratégicos com uma política nacional de resposta às emergências em saúde pública, reduzindo a dependência externa do país. Todavia, como não foi disponibilizado por estar em revisão, não foi possível avaliar em que medida contribui para a institucionalização dessa integração de forma consistente.

O MS informou ainda que está em elaboração o [24]Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta às Pandemias, com o objetivo de estabelecer um conjunto de diretrizes e medidas para fortalecer a resiliência do SUS. O Plano estabelece diretrizes e medidas voltadas à institucionalização integrada de ações que promovam a autossuficiência produtiva e reduzam a vulnerabilidade do país em cenários de ESP. Além disso, preveem a formalização de acordos internacionais de transferência de tecnologia, com vistas à ampliação da capacidade nacional de resposta.

Com a elaboração de diretrizes para fomento de pesquisas científicas e tecnológicas, o financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de desenvolvimento ou inovação em saúde, além do lançamento da Estratégia CEIS e o Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta às Pandemias, ocorre um passo em direção do objetivo de institucionalização da redução da dependência tecnológica do país, integrada à resposta às Emergências em Saúde Pública.

Diante do exposto, conclui-se que, embora ainda não exista uma política de saúde específica e formalmente institucionalizada para ESP — à semelhança da PNPDEC, que integra o fomento à pesquisa sobre eventos deflagradores de desastres — o Ministério da Saúde tem buscado desenvolver uma gestão de emergências baseada em riscos, orientada à redução de vulnerabilidades e promoção de resiliência de populações, territórios e do SUS. Nesse sentido, vêm sendo elaboradas normas e projetos voltados ao fomento à inovação e ao desenvolvimento de vacinas e insumos estratégicos, com vistas a diminuir a dependência externa e fortalecer as capacidades nacionais, em consonância com o paradigma proposto pela OMS.

[24] Por meio da Portaria GM/MS nº 1.334 de agosto/2023 foi instituído um GT para elaborar Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta à Pandemias. O DEMAS/SEIDIGI tem acompanhado as tratativas de elaboração do Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta à Pandemias que atualmente está em fase de finalização, aguardando revisão textual da Editora do Ministério da Saúde, e a análise nas instâncias formais previstas, como o GTVS e a CIT.

11. Fragilidade da institucionalização do Processo de lições aprendidas.

O presente tópico visa avaliar se a documentação de lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19 está prevista nas normas e se houve incorporação dessas lições no planejamento de longo prazo do MS.

O Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública (PRESP) estipula que as lições aprendidas de eventos reais ou simulados são a base utilizada para realização de revisão periódica dos protocolos e procedimentos de organização da resposta, como ação necessária à organização da capacidade de resposta, com o intuito de minimização dos riscos e redução, ao máximo, das suas consequências, como forma de gestão de riscos em emergências em saúde pública[25].

Com o intuito de organização da vigilância em saúde para resposta às emergências em saúde pública são padronizados formulários de implementação do plano de resposta à ESP, e devem ser construídos formulários a fim de consolidar informações estratégicas que subsidiarão a operacionalização do Coes, além da previsão de elaboração de modelo de relatório de lições aprendidas.

Outro ponto trazido pelo PRESP é que existem atividades que estão sob responsabilidade do COE, dentre elas a coordenação da avaliação pós-evento por meio de lições aprendidas. Além de diversas funções, incluindo a de coordenar a oficina sobre as lições aprendidas no encerramento de cada evento.

Adicionalmente, o componente de Monitoramento e Avaliação para Avaliação da Governança em Políticas Pública do TCU (BRASIL, 2014b) nos diz que a avaliação trata de: "[..] (vi) identificar as lições aprendidas e propor recomendações, de modo a reforçar os acertos e/ou, se necessário, ajustar, reorientar e modificar objetivos, metas, arranjos organizacionais e recursos (BUNIVICH, 1999)". Ainda mais, o Referencial do TCU cita como boas práticas a internalização de lições aprendidas antes do início de etapas subsequentes, o que pode promover o aperfeiçoamento da política de saúde.

Reforça-se que o mencionado referencial do TCU estipula que a elaboração de planejamento seja flexível e contínua, considerando que mudanças são inevitáveis durante a implantação para se ajustar a diferentes circunstâncias, novas informações, ou achados dos processos de avaliação e monitoramento (BRASIL, 2014b). O TCU (Acórdão nº 1533/2021) menciona também a importância do planejamento para eventos futuros que deve passar necessariamente pelo aprendizado que ficou pela experiência ocorrida pela Covid-19.

Acerca de identificação de riscos e ameaças, que podem ter as lições aprendidas como ferramenta de identificação, o PNDPEC define como competência da União apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de

[25] Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

11.1 Situação observada durante a pandemia de Covid 19.

Sobre a oficina de lições aprendidas, o MS informou que realizou uma Reunião Nacional de Síndromes Gripais e Avaliação da Resposta da Vigilância para a pandemia da covid-19 no Brasil e que a reunião e seus encaminhamentos foram registrados no Relatório de Gestão de 2022. Ao examinar o relatório, foi possível verificar que ele apresenta as informações sobre o enfrentamento da Pandemia de Covid-19, com ações e perspectivas para 2023.

Sobre a Reunião Nacional de Síndromes Gripais e Avaliação da Resposta da Vigilância para a pandemia da covid-19 no Brasil, considerando as informações dadas de que *a "reunião foi registrada no Relatório de Gestão do Ministério da Saúde de 2022"*[26], não restou demonstrado que foi efetivamente uma oficina sobre lições aprendidas de experiências advindas de uma análise situacional abrangente, levando em conta o período da emergência da Covid-19, uma vez que carece de desenvolvimento de temas típico de gestão, institucionalização, coordenação, tomadas de decisão, integração, participação e articulação na resposta às Emergências em Saúde Pública. Elementos esses de suma importância para institucionalizar melhorias no processo de resposta às ESP, bem como na institucionalização de resiliência e redução de vulnerabilidades, como apontado no item 08 deste relatório.

11.2 Situação atual

Sobre a incorporação das lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19 no planejamento de longo prazo do Ministério da Saúde, verificou-se que, a Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (CGVDI) informou que a área técnica da vigilância da covid-19 (à época sob atribuição da Coordenação-Geral de Vigilância das Síndromes Gripais (CGGRIPE) proveu subsídios técnicos para a elaboração da Nota Informativa nº 4/2022/NUJUR/SVS/MS de 13.04.2022, com o objetivo de responder às perguntas sobre os impactos da revogação da portaria da Espin de covid-19, as estratégias de mitigação, e o plano de retomada frente a uma possível piora do cenário epidemiológico da covid-19 no contexto da revogação da Espin.

Informou-se ainda que as informações contidas na Nota Informativa supracitada foram incorporadas no documento "Relatório Técnico - Espin covid-19", publicado em abril de 2022 pela então Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do MS.

O Plano Nacional de Saúde 2024-2027 traz atualização na meta sobre as ESP, atualizando para "Ampliar a cobertura das redes de preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública por regiões de saúde" e um novo indicador "Percentual de regiões de saúde com a presença de serviços de CIEVS, RENAVEH, VIGIDESASTRES e profissionais capacitados no EPISUS Fundamenta".

[26] Resposta do MS ao questionamento feito pela CGU na Solicitação de auditoria 04, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 1/2024-DPNI/SVSA/MS, p.26.

O MS elaborou o Plano de Enfrentamento das Ações de Vigilância em Saúde da Covid-19 no Período Pós-Emergência em Saúde Pública Nacional e Internacional (o Plano), com o objetivo de apresentar as ações de vigilância em saúde da SVSA/MS para o enfrentamento da covid-19 no período pós emergência em saúde pública nacional e internacional, no que compete às vigilâncias epidemiológica, genômica e laboratorial, além das estratégias de vacinação, afim de uma atuação coordenada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, em 2025, o DEMSP/SVSA/MS desenvolveu um Guia de Avaliação Pós-evento para Emergência Em Saúde Pública, ainda não publicado, em que propõe quatro metodologias principais para realizar a [27]Avaliação Pós-Evento (APE).

É importante destacar também que além de o PRESP apontar as atividades que estão sob responsabilidade do COE, dentre elas a coordenação da avaliação pós-evento por meio de lições aprendidas, incluindo a de coordenar a oficina sobre as lições aprendidas no encerramento de cada evento, há também ações com o intuito de organização da vigilância em saúde para resposta às emergências em saúde pública, em que são padronizados formulários de implementação do plano de resposta à ESP, que devem ser construídos a fim de consolidar informações estratégicas que subsidiarão a operacionalização do Coes[28].

Evidencia-se que, acerca do tema, não foi disponibilizado pelo MS o documento acima com as informações, como previstas no PRESP, que carece de informações claras e objetivas sobre o procedimento de lições aprendidas no contexto de ESP, assim como não tem força normativa suficiente para que tenha seus dispositivos seguidos pelo MS, da maneira em que está ajustado. Esse detalhe se remete ao ponto 08, em que se destaca a falta de institucionalização formal do PRESP, deixando-o apenas como informação sugestiva em várias situações.

Ainda, a SVSA informou que detém apenas parcialmente informações sobre a resposta à Pandemia de Covid-19 e somente para o período de 22.01 a 24.04.2020, uma vez que após a extinção da Secovid (que exerceu a função de representante do MS na coordenação das medidas a serem executadas durante a Espin decorrente do coronavírus), as informações passaram a algum setor – não informado pelo MS – que assumiu o seu passivo, e não à secretaria com a expertise para coordenar as emergências em saúde pública[29]. Essa descoordenação prejudica a incorporação de lições aprendidas e limita a atuação da SVSA.

O TCU, ainda em 2020, trouxe como referência internacional informações de uma agência de governo que atua com a resposta e a mitigação dos efeitos dos acidentes de qualquer causa, tamanho e complexidade. E, por meio da sua área técnica, também se manifestou acerca do risco da mudança de responsabilidade da gestão do COE ao longo da gestão da pandemia, que a ausência de evidências de que a SVSA não possuía capacidade administrativa para manutenção do COE sob sua responsabilidade, levantava dúvidas acerca da necessidade de

[27] A Avaliação Pós-Evento (APE) é uma estratégia que visa institucionalizar o processo de lições aprendidas nas respostas às emergências em saúde pública.
[28] Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública, p.17

[29] Item 4.1.1 Mudanças de responsabilidade na gestão do COE, com prejuízo para a resposta à pandemia de Covid-19.

troca, devido ao risco de perda de conhecimento e de coordenação, o que prejudica a incorporação de lições aprendidas durante a pandemia e o aperfeiçoamento das instituições.

Encerrando esse tópico, conclui-se que embora a documentação de lições aprendidas esteja prevista no PRESP e em referenciais como do TCU utilizados aqui como critério, o processo de realização dessas lições aprendidas carece de institucionalização formal clara e objetiva.

Por fim, que a incorporação das lições aprendidas no planejamento de longo prazo do Ministério da Saúde não ocorreu de forma satisfatória, uma vez que as informações contidas nos relatórios mencionados pelo MS trazem informações mais voltadas a questões epidemiológicas, restando ausente questões como institucionalização, coordenação, tomadas de decisão, integração, participação e articulação e gestão, conforme as boas práticas de planejamento flexível e contínuo do TCU, em conjunto com a Portaria GM/MS nº 2.135, de 25.09.2013, o PRESP e a abordagem para gestão baseada em riscos das ESP (EDRM), proativa e como base em todas as ameaças conforme proposta pela OMS.

À situação anteriormente apresentada, podem ser atribuídas a duas causas: a primeira é a fragilidade da institucionalização formal da documentação e utilização de lições aprendidas; e a segunda é pela possível falta de informações disponível à SVSA que possam ser utilizadas para orientar eventuais redirecionamentos do plano de longo prazo do MS.

Pode-se apontar as seguintes consequências na frágil institucionalização do processo de lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19; manutenção do risco de reincidência e perpetuação de erros na resposta às respostas as Espin; manutenção do país aos efeitos de novas calamidades; e ausência de identificação e incorporação das lições aprendidas.

RECOMENDAÇÕES

1. Propor ao Governo Federal, às instâncias legislativas e às instâncias competentes do SUS — incluindo CNS, CONASS e Conasems — a consolidação, ampliação e formalização, mediante Lei, de uma "Política Pública de Estado Específica para ESP", integrada e baseada em riscos, com ênfase em prevenção e redução de vulnerabilidades. Buscando potencializar o arcabouço normativo, institucional e operacional já existente — como o Decreto nº 7.616/2011, as conclusões do grupo de trabalho que finalizou a elaboração do Plano Estratégico para Prevenção, Preparação e Resposta às Pandemias (Portaria GM/MS nº 1.334/2023), do grupo de trabalho interinstitucional (Portaria GM/MS nº 167/2025), o fortalecimento do COE, os planos de contingência e as oficinas e simulados realizados em todas as Unidades da Federação — e ter como referências a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) e o *Emergency Disaster Risk Management Framework* (OMS, 2019), bem como as demais recomendações deste relatório.

   Achados n° 1 ao 11.

2. Consolidar e instituir por meio de ato normativo de caráter permanente, no âmbito das instâncias de resposta às ESP que atuam no Ministério da Saúde, inclusive o COE, o Processo Decisório com diretrizes e princípios norteadores (incluindo os da precaução e prevenção), o qual contemple a participação das partes interessadas, os atributos transparência, fundamentação em evidências e orientação a riscos.

   Achados n° 2 e 4

3. Instituir formalmente, no âmbito das instâncias de resposta às ESP que atuam no MS, a participação dos representantes dos entes federados, especialistas de notório saber, instituições representativas de saúde pública, instituições com atuação relevante na resposta às ESP, além dos representantes da sociedade civil no âmbito do SUS, inclusive no COE, naquilo em que for aplicável.

   Achados n° 3 e 4

4. Definir em norma apropriada as competências de coordenação do Ministério da Saúde, estabelecendo: a SVSA como instância central de coordenação técnica da prevenção, preparação, vigilância, resposta e recuperação às ESP; o DEMSP/SVSA como órgão executor permanente; o COE como instância legal de comando e controle operacional, com competências de ativação, protocolos, coordenação interfederativa; e a obrigação do MS de assegurar a direção nacional, prevenindo sobreposições e esvaziamento de funções.

   Achados n° 4 e 5

5. Instituir formalmente, por ato normativo de caráter permanente, uma política de comunicação coordenada em saúde para o enfrentamento das ESP, fundamentada em transparência ativa e integrada ao Núcleo de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário do DEMSP/SVSA, com diretrizes e objetivos claros para comunicação de riscos, mobilização social, combate à desinformação, linguagem acessível e definição de responsabilidades.

   Achado n° 6

6. Instituir, por norma legal apropriada, o planejamento da resposta às ESP, estabelecendo estrutura, objetivos e elementos mínimos para um plano nacional, planos de contingência e planos de ação, à semelhança da PNPDEC. Esse marco deve contemplar: prazos e revisões periódicas; participação ampla dos representantes dos entes federados e dos representantes da sociedade; diretrizes de ação governamental; identificação de riscos regionais e populacionais; processo decisório baseado em evidências e nos princípios da prevenção e precaução; gestão sistemática de riscos; critérios de atualização; incorporação das lições aprendidas; visão de futuro voltada à resiliência; e apoio técnico e normativo aos estados e municípios para assegurar o alinhamento entre os planos das diferentes esferas.

Achado n° 8

7. Instituir formalmente o processo de lições aprendidas após cada ESP encerrada, mediante norma apropriada, estabelecendo objetivos, diretrizes, participação, procedimentos, resultados e produtos esperados, inclusive a especificação dos conteúdos do relatório final e formas de aplicação e de incorporação no planejamento do MS.

Achados n° 7 e 11

8. Promover, em articulação com o DATASUS e áreas técnicas responsáveis, uma oficina nacional de lições aprendidas voltada à identificação e sistematização dos principais problemas de TIC que impactaram a resposta à pandemia de COVID-19 e a outras ESP.

Achados n° 7 e 11

CONCLUSÃO

A avaliação realizada nesta auditoria demonstra lacunas e fragilidades na governança da resposta governamental às Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional, avaliadas sob a perspectiva da institucionalização. Em última análise, a falta de uma política pública de Estado específica para resposta às ESP é considerada causa mediata ou imediata dos principais problemas relevantes constatados na resposta governamental à pandemia de Covid-19 e um risco para a reincidência dos referidos problemas em futuras ESP, favorecendo também a persistência de vulnerabilidades da população, do SUS e do país a calamidades sanitárias, resultados em saúde insatisfatórios, prejuízos econômicos e mortalidade evitáveis.

As melhorias identificadas exigem tanto ações no âmbito do Ministério da Saúde quanto um esforço nacional coordenado, com institucionalização de uma política pública de Estado para resposta às ESP, de modo a mitigar riscos, promover resiliência e evitar a reincidência de falhas semelhantes às constatadas na pandemia de Covid-19.

Os exames de auditoria consistiram na execução de procedimentos para responder a quatro "Questões de Auditoria", explicitadas na introdução deste relatório. Os achados estão detalhados no capítulo "Resultado dos Exames". Seguem as respostas às referidas questões:

1. No Brasil não há institucionalização formal de uma política pública de Estado específica para enfrentamento de emergências em saúde pública, por meio de norma legal apropriada, emitida por órgão dotado de legitimidade e competência para fazê-lo, e na qual se normatize a atuação dos diversos órgãos, instituições e esferas de governo envolvidos. Referências para tal política são a PNPDEC e a abordagem integrada de gestão de emergências em saúde pública e de desastres ambientais proposta pela OMS, a qual é baseada em riscos, com ênfase em prevenção, preparação, resposta e recuperação, além de prontidão, integrada em políticas e estratégias relevantes e apoiadas por legislação apropriada. Nesse sentido, os atos normativos que institucionalizam o enfrentamento de ESP no país apresentam lacunas e/ou fragilidades, pois: (a) não estabelecem um processo o decisório transparente, fundamentado em evidências, orientado a riscos, motivado pela equidade, orientado para atender ao interesse público e que apoie a participação social. Ademais, o processo decisório não é fundamentado nos princípios da prevenção e da precaução, nas decisões em que são aplicáveis; (b) não estabelecem adequadamente a participação efetiva das partes interessadas no processo decisório e na formulação de políticas, inclusive os entes públicos de outras esferas de governo e instâncias de natureza técnico-científica correlatos às ações de enfrentamento das ESP, nem da sociedade civil; carecem de força normativa para promover a adequada estabilidade institucional – inclusive no âmbito do SUS como um todo – e para evitar mudanças prejudiciais intempestivas e/ou frequentes, interferências prejudiciais ao desempenho de funções técnico-especializadas essenciais (especialmente no âmbito de atuação do COE) e ao processo de lições aprendidas.

2. Não há também normas formalmente instituídas segundo princípios e boas práticas de governança, que estabeleçam adequadamente as bases para o planejamento da resposta às ESP e para a elaboração de planos de contingências de âmbito nacional pelo MS, alinhados com o RSI, com o referencial da OMS baseado em riscos para gestão de emergências em saúde

e desastres, sequer com a gestão de riscos estabelecida no Decreto nº 9.203/2017. Contudo, destaca-se que houve avanços no fomento à inovação e ao desenvolvimento de vacinas e insumos estratégicos, voltados à redução da dependência externa. Por fim, o processo de lições aprendidas não foi realizado a contento e não houve incorporação do aprendizado da última pandemia de Covid-19 ao planejamento estratégico do Ministério da Saúde;

3. A institucionalização de mecanismos de liderança do Ministério da Saúde na coordenação intersetorial e intergovernamental entre os atores envolvidos no enfrentamento de emergências em saúde pública é deficiente, de modo que não promove a articulação efetiva entre o MS e a União com as demais esferas de governo e tendo em conta as redes transorganizacionais e relações de interdependência;

4. A institucionalização dos arranjos para promoção da *accountability* no âmbito do MS e da União não preveem mecanismos e instrumentos adequados de comunicação e de transparência das ações relativas ao enfrentamento das ESP.

Dito isso, dentre os benefícios das recomendações desta auditoria registra-se a contribuição para o aperfeiçoamento da governança no âmbito do Ministério da Saúde e da resposta governamental às Emergências em Saúde Pública. Tudo isso pode, em última análise, reduzir os riscos de reincidência em futuras ESP de falhas relevantes constatadas na resposta governamental à pandemia de Covid-19, além de contribuir para resultados em saúde melhores e incremento da imagem institucional do MS.

Enquanto boas práticas identificadas durante a auditoria e favoráveis ao aperfeiçoamento da governança na resposta às ESP, são relacionadas as seguintes:
a) Instituição da Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública (CTA-ESP), por meio da Portaria GM/MS nº 440/2023, de 03.04.2023, de caráter consultivo, com o objetivo de avaliar os aspectos técnicos e científicos necessários para a condução de potenciais emergências em saúde pública e eventos que tenham sido declarados como emergências em saúde pública de importância nacional - ESPIN ou internacional - ESPII. A referida Câmara possui composição que contempla ampla participação de diferentes partes interessadas;
b) Publicação da Portaria GM/MS n. º 4.282, de 12.12.2022, com o objetivo de estabelecer diretrizes para o financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de desenvolvimento ou inovação em saúde pelo MS;
c) Instituição da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Estratégia CEIS), por meio do Decreto nº 11.715/23, com a finalidade de redução da vulnerabilidade do SUS, dentre outras. A estratégica explicita, dentre os seus objetivos, o suporte à preparação e ao enfrentamento de emergências e necessidades de saúde, além de impulsionar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no âmbito da saúde;
d) Instituição do Centro de Operações de Emergências para a situação de chuvas intensas e inundações na Região Sul, no âmbito do Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 3.697, de 3.05.2024 que, ao contrário do que foi instituído formalmente para o COE até a pandemia de Covid-19, agora conta com representantes de partes interessadas externas ao órgão e/ou ao Governo Federal, como é o caso da Anvisa, Fiocruz; CONASS; Conasems; e OPAS. são instituições representativas da saúde pública e de entes públicos das demais esferas de governo, o que tende a favorecer o aperfeiçoamento da governança na resposta às ESP; e)

Portaria GM/MS nº 167, de 11.03.2025, que institui o Grupo de trabalho para elaborar propostas que subsidiem ampliar a capacidade do estado brasileiro e fortalecer o SUS para enfrentar epidemias, pandemias e emergências em saúde pública no Brasil;
f) Instituição de câmaras técnicas consultivas, como a CTA-Covid (Portaria GM/MS nº 3.098/2024), que envolvem entes tripartites e especialistas;
g) Portaria GM/MS nº 7.235, de 16.06.2025, a Sala de Situação Nacional para Monitoramento e Resposta à Infecção por Vírus Respiratórios, incluindo a Influenza Aviária, com a finalidade de coordenar e integrar as ações estratégicas de vigilância, prevenção, comunicação de risco e resposta a possíveis impactos à saúde pública decorrentes de vírus respiratórios associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da ocorrência de Influenza Aviária no território nacional; e
h) Guia de Avaliação Pós-evento para Emergência Em Saúde Pública, ainda não publicado, em que se propõe quatro metodologias principais para realizar a Avaliação Pós-Evento (APE).

Por fim, oportuno mencionar que há outros apontamentos registrados nos achados que, mesmo não sendo objeto de recomendações, podem subsidiar iniciativas do Ministério da Saúde e das instituições do SUS em geral para aperfeiçoar suas rotinas e procedimentos.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Por meio dos Ofícios nº 1043/2025/CGDOC/AECI/MS, de 25.09.2025, e nº 1058/2025/CGDOC/AECI/MS, de 29.09.2025, a Unidade encaminhou manifestações de várias áreas técnicas em reposta ao Relatório Preliminar, especialmente do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMS) da SVSA e do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI).

Já o Departamento de Doenças Transmissíveis (DEDT) da SVSA informou que não tem informações adicionais a apresentar além daquelas já disponibilizadas na Nota Técnica nº 34/2025 CGCOVID/DEDT/SVSA/MS, de 08.08.2025, já analisadas durante a execução dos trabalhos de auditoria.

Recomendação nº 1 (Achados n° 1 ao 11)

Manifestação da unidade auditada

O Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA) apresentou a seguinte manifestação:

> Comentário geral
>
> Inicialmente, é importante destacar que a utilização exclusiva do conceito de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) como referência para a formulação das recomendações apresenta limitações. Embora o Decreto nº 7.616/2011 seja um marco normativo fundamental, sua aplicação abrange apenas situações específicas e restritivas. A experiência recente do SUS demonstra que diversas outras emergências em saúde pública — como desastres climáticos, crises de desassistência, epidemias e surtos regionais de doenças transmissíveis — exigiram resposta nacional articulada e mobilização de recursos, mesmo sem a formalização de uma ESPIN. Nesse sentido, sugere-se que a redação das recomendações seja ajustada para contemplar de forma mais ampla o conjunto das situações enfrentadas pelo sistema de saúde, utilizando a expressão: "Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e outras emergências de impacto relevante para o SUS". Essa formulação assegura maior aderência à realidade vivenciada e amplia a efetividade das medidas propostas. Com vistas a conferir maior clareza e abrangência às recomendações, sugere-se que utilizar o termo 'Emergências em Saúde Pública (ESP)', no qual entende-se que estarão contempladas as Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional e outras emergências em saúde pública de impacto relevante para o SUS. Dessa forma, evita-se a repetição de uma redação extensa em cada recomendação, ao mesmo tempo em que se assegura que o conceito utilizado seja suficientemente abrangente para contemplar tanto as ESPIN formalmente declaradas quanto outras emergências que exigiram resposta nacional do SUS.
> (...)

Conclusão

As manifestações aqui apresentadas dialogam diretamente com o processo de atualização normativa em curso no âmbito do Ministério da Saúde. As recomendações da CGU foram analisadas pelo DEMSP à luz desse movimento, de modo a garantir coerência entre as propostas de melhoria apontadas pela auditoria e as iniciativas já em andamento. O DEMSP reconhece a relevância das recomendações apresentadas pela CGU e entende que elas contribuem para o fortalecimento da governança do SUS frente às ESP. Algumas medidas propostas se encontram em curso no âmbito do Ministério da Saúde, como a elaboração do Projeto de Lei para as ESP em discussão no Gabinete do Ministro, os objetivos estratégicos do SAGA SUS, a atualização do Regimento Interno, bem como a publicação do Guia de Comunicação de Risco e do Guia de Avaliação Pós-Evento. Dessa forma, considera-se que as recomendações podem ser incorporadas de maneira articulada às iniciativas já em andamento, evitando sobreposição de esforços e garantindo maior efetividade na institucionalização de processos.

Em relação às Recomendações 1 e 2:

Considera-se pertinente a proposta de construção de uma política pública de Estado para as ESP. Contudo, recomenda-se a retirada da palavra "resposta" da redação apresentada, de modo que a política não se restrinja apenas a essa fase, mas contemple também as demais etapas do ciclo de gestão das emergências, incluindo prevenção, preparação, recuperação e a vigilância, que é transversal.

Reitera-se que está em construção atualmente a Política Nacional de Enfrentamento das Emergências em Saúde Pública em elaboração junto ao Gabinete do Ministro, bem como o fato de que a criação dessa política é um dos objetivos estratégicos da Sala de Situação de Apoio à Gestão Ágil do SUS (SAGA-SUS).

Sugestão de novo texto da recomendação do DEMSP:

1. Propor ao Governo Federal, às instâncias legislativas e às instâncias competentes do SUS — incluindo CNS, CONASS e Conasems — a consolidação, ampliação e formalização, mediante Lei, de uma política pública de Estado específica para as ESP, integrada e baseada em riscos, com ênfase em prevenção e redução de vulnerabilidades.

Análise da equipe de auditoria

Cabe registrar, inicialmente, que a Unidade concorda com os fatos e recomendações, informando ações já realizadas e propondo medidas de aperfeiçoamento, tornando-as mais assertivas e aderentes à realidade institucional.

Entende-se relevante e pertinente a observação da Unidade Auditada em relação à alteração do termo Espin para o termo 'Emergências em Saúde Pública (ESP)', neste sentido concorda-se que essa formulação confere maior clareza e abrangência às recomendações, contemplando todas as Emergências em Saúde Pública de impacto relevante para o SUS. Assim, tanto as recomendações quanto o texto do Relatório, no que couber, serão ajustados.

Concorda-se também com a retirada do termo resposta, de modo que a política contemple também as demais etapas da gestão das emergências, ou seja, prevenção, preparação, recuperação e a vigilância.

Recomendação nº 2 (Achados n° 2 e 4)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

> No que se refere ao processo decisório, sugere-se a retirada da menção à CTA-Covid, tendo em vista que a CTA é um espaço de caráter não permanente, sem natureza decisória. Cabe destacar que atualmente existe a Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública - CTA-ESP (instituída por meio da Portaria GM/MS Nº 440, de 3 de abril de 2023), de caráter consultivo, no âmbito da qual são realizadas reuniões com especialistas de notório saber para apoiar discussões técnicas relevantes relacionadas às ESP.

Especificamente sobre esta recomendação, o DEMSP sugere o aperfeiçoamento do texto nos seguintes termos:

> 2 - No âmbito das instâncias de resposta às ESP que atuam no Ministério da Saúde, inclusive o COE, consolidar e instituir, por meio de ato normativo de caráter permanente, o processo decisório com diretrizes e princípios norteadores — incluindo os da precaução e prevenção —, o qual contemple a participação das partes interessadas, os atributos transparência, fundamentação em evidências e orientação a riscos.

Análise da equipe de auditoria

A Unidade concorda com a recomendação, sugerindo a retirada da menção à CTA-Covid, tendo em vista que a CTA é um espaço de caráter não permanente, e que atualmente existe a Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública - CTA-ESP (instituída por meio da Portaria GM/MS Nº 440, de 3.04.2023), de caráter consultivo, no âmbito da qual são realizadas reuniões com especialistas de notório saber para apoiar discussões técnicas relevantes relacionadas às ESP. Acata-se a proposição da Unidade.

Recomendação nº 3 (Achados n° 3 e 4)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

> Concorda-se com a importância de ampliar a participação de diferentes atores nas instâncias de resposta às ESP. Atualmente, a prática do DEMSP é convidar os representantes institucionais dos entes federados, já previstos no âmbito do SUS, como o CONASS e o CONASEMS. Não é viável incluir todos os entes federados diretamente no COE, uma vez que a composição precisa ser operacional e funcional para garantir agilidade no processo de tomada de decisão. Da mesma forma, a representação da sociedade civil, atualmente, tem se dado por meio do CNS, instância legítima de deliberação e participação social no SUS. O CNS pode convidar ou indicar especialistas para participar ou o representar no COE. Contudo, não há, de fato, uma norma que obrigue o MS a incluir nos COE as instituições citadas. O DEMSP concorda que esta norma deve ser elaborada.

Ainda, o DEMSP apresentou sugestão de aperfeiçoamento da recomendação:

> 3 – No âmbito das instâncias de resposta às ESP que atuam no MS, instituir formalmente a participação dos representantes dos entes federados, especialistas de notório saber, instituições representativas de saúde pública, instituições com atuação relevante na resposta às ESP, além dos representantes da sociedade civil no âmbito do SUS, inclusive no COE, naquilo em que for aplicável**.**

Análise da equipe de auditoria

Também em relação a esta proposta, a Unidade concorda com o achado e a recomendação, destacando a importância de ampliar a participação de diferentes atores nas instâncias de governança das ESP. Contudo, afirma que não é viável incluir todos os entes federados diretamente no COE, assim como a representação da sociedade civil deve se dar por meio do CNS, instância legítima de deliberação e participação social no SUS. Neste sentido, propõe incluir no texto da recomendação que esta participação deve ser normatizada prevendo a participação de representantes das instâncias legítimas do SUS (CONASS, Conasems e CNS), com o que se concorda.

Recomendação nº 4 (Achados n° 4 e 5)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

Em relação às recomendações 4 e 5 apresentou a seguinte manifestação:

> Considera-se pertinente a recomendação de definir com maior clareza as competências do Ministério da Saúde na coordenação das emergências em saúde pública. Contudo, sugere-se ampliar o escopo da recomendação para contemplar todas as fases do ciclo de gestão das ESP — prevenção, preparação, vigilância, resposta e recuperação — e não apenas a resposta.
>
> Ressalta-se que não é adequado restringir a atuação do DEMSP à execução do PRESP e à pronta resposta, uma vez que suas atribuições são mais amplas e já estão disciplinadas em normativa do Ministério da Saúde que dispõe sobre as competências de cada departamento. Destaca-se que há uma proposta de atualização das competências do DEMSP no novo Regimento Interno do Ministério da Saúde, em fase de elaboração, que contempla as recomendações, devendo ser complementada por portarias específicas.

Também em relação a esta recomendação, o DEMSP apresentou sugestão de aperfeiçoamento:

> 4 – Definir em norma apropriada as competências de coordenação do Ministério da Saúde, estabelecendo: a SVSA como instância central de coordenação técnica da prevenção, preparação, vigilância, resposta e recuperação às ESP; o DEMSP/SVSA como órgão executor permanente; o COE como instância legal de comando e controle operacional, com competências de ativação, protocolos, coordenação interfederativa; a obrigação do MS de assegurar a direção nacional, prevenindo sobreposições e esvaziamento de funções

Análise da equipe de auditoria

Mais uma vez a Unidade concorda com a recomendação, contudo, sugere ampliar o escopo da recomendação para contemplar todas as fases do ciclo de gestão das ESP — prevenção, preparação, vigilância, resposta e recuperação — e não apenas a resposta, com o que se concorda. Concorda-se também que a gestão do DEMSP não deve se restringir apenas como órgão executor permanente responsável pelo PRESP e pela pronta resposta. Embora a redação anterior não excluísse as demais funções, concorda-se com o ajuste a fim de dar maior clareza ao texto.

Recomendação nº 5 (Achado n° 6)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

> No que se refere à comunicação, destaca-se que o Guia de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário em Emergências de Saúde Pública, atualmente em processo de publicação pelo Ministério da Saúde, já avança nesta pauta.

O DEMSP apresentou ainda sugestão de aperfeiçoamento da recomendação:

> 5 - Instituir formalmente, por ato normativo de caráter permanente, uma política de comunicação coordenada em saúde para o enfrentamento das ESP, fundamentada em transparência ativa e integrada ao Núcleo de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário do DEMSP/SVSA, com diretrizes e objetivos claros para comunicação de riscos, mobilização social, combate à desinformação, linguagem acessível e definição de responsabilidades.

Análise da equipe de auditoria

A Unidade concorda com a recomendação, limitando-se a sugerir uma nova redação da recomendação com a substituição do termo Espin por ESP, o que já foi analisado anteriormente e com o que se concorda.

Recomendação nº 6 (Achado n° 8)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

> Embora seja pertinente a proposição de diretrizes gerais para o planejamento da resposta às emergências em saúde pública, entende-se que alguns trechos da recomendação precisam ser ajustados. Sugere-se suprimir a palavra “regras” e “critérios”, uma vez que os planos devem ser instrumentos técnicos e operacionais, preservando a flexibilidade necessária para adaptação às especificidades de cada emergência. Da mesma forma, recomenda-se suprimir a menção aos mecanismos de avaliação e prestação de contas anual, pois tais dispositivos estão vinculados a processos administrativos e de gestão mais amplos do SUS, não devendo constar nos planos de resposta e contingência. Por fim, propõe-se também a supressão do trecho relativo à integração ao planejamento estratégico do MS, por não guardar relação direta com o escopo dos planos. Mantidas essas adequações, considera-se a recomendação pertinente e possível de implementação.

Ainda, reproduz-se a sugestão do DEMSP de melhoria da recomendação:

> 6 – Instituir, por norma legal apropriada, o planejamento da resposta às ESP, estabelecendo estrutura, objetivos e elementos mínimos para um plano nacional, planos de contingência e planos de ação, à semelhança da PNPDEC. Esse marco deve contemplar: prazos e revisões periódicas; participação ampla dos representantes dos entes federados e dos representantes da sociedade; diretrizes de ação governamental; identificação de riscos regionais e populacionais; processo decisório baseado em evidências e nos princípios da prevenção e precaução; gestão sistemática de riscos; critérios de atualização; incorporação das lições aprendidas; visão de futuro voltada à resiliência; e apoio técnico e normativo aos estados e municípios para assegurar o alinhamento entre os planos das diferentes esferas.

Análise da equipe de auditoria

Novamente a Unidade se manifestou concordando com a pertinência da recomendação, contudo, sugere a alteração de alguns termos para que esteja em adequação às atribuições desempenhadas pela Unidade. Concorda-se com as alterações propostas e acata-se a nova proposta de recomendação apresentada pela Unidade, por apresentar melhorias à redação sem alterar a sua substância.

Recomendação nº 7 (Achados n° 7 e 11)

Manifestação da unidade auditada

Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP/SVSA):

> A recomendação apresentada é considerada pertinente e a formalização do processo de lições aprendidas é uma melhoria necessária. Porém, alguns ajustes são propostos. Em primeiro lugar, destaca-se que nem toda emergência em saúde pública é formalmente declarada, razão pela qual se sugere a supressão dessa referência específica na redação. Ademais, informa-se que o Ministério da Saúde já avançou nessa agenda e encontra-se em fase de finalização a publicação do Guia de Avaliação Pós-Evento, cuja minuta preliminar segue anexa a esta manifestação (0050623076). Contudo, a CGU acerta ao recomendar a formalização, pois a existência do Guia não garante a sua utilização. Cabe ainda ressaltar que não é atribuição do processo de lições aprendidas estabelecer o processo decisório das emergências, visto que sua função é de caráter avaliativo e propositivo. O processo decisório poderá ser discutido e objeto de recomendações a partir das análises realizadas, mas não deve constar como elemento constitutivo da normativa que trata das lições aprendidas, e sim do Código Sanitário discutido no item 4 acima.

Também para este termo, o DEMSP apresenta proposta de melhoria da recomendação:

> 7 – Instituir formalmente o processo de lições aprendidas após cada ESP encerrada, mediante norma apropriada, estabelecendo objetivos, diretrizes, participação, procedimentos, resultados e produtos esperados, inclusive a especificação dos conteúdos do relatório final e formas de aplicação e de incorporação no planejamento do MS. Além disso, promover, em articulação com o DATASUS e áreas técnicas responsáveis, uma oficina nacional de lições aprendidas voltada à identificação e sistematização dos principais problemas de TIC que impactaram a resposta à pandemia de COVID-19 e a outras ESP.

Por fim, a Coordenação-Geral de Inovação e Informática em Saúde (CGIIS) do DATASUS apresentou a seguinte manifestação:

> Em atenção ao Despacho Datasus 0050275578, esta Coordenação-Geral de Inovação e Informática em Saúde Informa que com base nas lições aprendidas durante a pandemia da Covid-19, vem desenvolvendo ações em parceria com o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) e outras coordenações do Ministério da Saúde, com vistas a aprimorar a governança e a interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde.
> Entre as iniciativas em curso, destacam-se:
> • Aprimoramento da interoperabilidade dos sistemas de imunização, com foco na melhoria dos processos de integração, bem como dos modelos informacionais e computacionais mais atualizados relacionados aos Registros de Imunobiológicos Administrados, tanto em Campanhas quanto em Rotina (RIA-C e RIA-R);
> • Disponibilização de documentação técnica atualizada para os integradores, com incentivo ao uso do padrão internacional HL7 FHIR, de modo a padronizar e qualificar a troca de informações em saúde;
> • Substituição de processos legados, como o Thrift, por mecanismos modernos e ágeis, com utilização de ferramentas institucionais do Ministério da Saúde (como o PEC e-SUS), garantindo maior tempestividade e confiabilidade na disponibilização de dados nas plataformas do SUS Digital (Meu SUS Digital, SUS Digital Profissional e, em breve, SUS Digital Gestor).
> • Capacitação e apoio aos integradores, por meio da elaboração de materiais técnicos, cursos, manuais, lives e guias práticos, com o objetivo de ampliar a proficiência no uso do padrão HL7 FHIR, reduzindo gargalos e facilitando a integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Dessa forma, a CGIIS reafirma seu compromisso em contribuir para o fortalecimento da governança digital em saúde, promovendo maior integração, eficiência e transparência na utilização dos sistemas de informação do SUS, em alinhamento com as recomendações constantes do Item 7 do Relatório Preliminar de Auditoria nº 1379967.

Análise da equipe de auditoria

A Unidade considera pertinente a proposta da recomendação, propondo a substituição de alguns termos para que se ajuste tecnicamente aos termos técnicos utilizados pela Unidade. Aponta também que está avançando no assunto com a produção do Guia de Avaliação Pós-Evento, que está em estágio de minuta preliminar, enfatizando que a existência de um guia não garante a sua utilização, sendo necessário que seja publicado por meio de norma apropriada que determine a sua utilização pela administração pública. Sobre a parte final da recomendação, o DataSUS se manifestou informando a realização de ações voltadas à identificação e melhoria dos problemas de TIC apresentados.

Acata-se as alterações propostas pela Unidade para a recomendação, que contribuem para a clareza da sua redação, sem alterar o seu conteúdo. Quanto à minuta preliminar do guia pós-evento disponibilizado, entende-se que ele contém os elementos mínimos para formalização do processo de lições aprendidas, contudo, ressalta-se a necessidade de publicação em norma apropriada que vincule o gestor quando preenchidos os requisitos para sua utilização. Concorda-se também com as ações tomadas pelo DATASUS para cumprimento da recomendação.

II – As Instituições de Resposta às ESP no Brasil.

As instituições voltadas à preparação e resposta às Emergências em Saúde Pública de no Brasil podem ser agrupadas em dois blocos: estruturas permanentes (pré-Covid-19) e estruturas criadas ou adaptadas durante a pandemia.

1. Estruturas permanentes antes da Covid-19

1.1 Regulamento Sanitário Internacional (RSI)

Revisado em 2005 e aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 395/2009, o RSI estabelece padrões globais de preparação e resposta a emergências de saúde pública. Constitui-se como referência central para orientar a vigilância nacional e as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

1.2. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS)

Instituída pela Resolução CNS nº 588/2018, sem base em lei, a PNVS é reconhecida como política pública de Estado e função essencial do SUS. Define emergência em saúde pública como situação que demanda medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos. Entre suas diretrizes, está a de detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública em consonância com o RSI, sob responsabilidade da União, por meio da SVSA/MS e da Anvisa.

1.3. Mecanismos de resposta

Antes da pandemia, já estavam instituídos diversos mecanismos de resposta:

- A Declaração de Espin, prevista no Decreto nº 7.616/2011, ato do Ministro da Saúde para acionar medidas excepcionais;
- O Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE), concebido como órgão de coordenação da resposta nacional;
- Os Comitês de Monitoramento de Eventos (CME), os Planos de Contingência e as Salas de Situação;
- O Sistema Integrado de Monitoramento de Eventos (SIME) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS); e
- A Força Nacional do SUS (FN-SUS) e a Rede VigiAR-SUS.

2. Estruturas criadas ou adaptadas durante a Covid-19

2.1 Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII)

Reinstituído pelo Decreto nº 10.211/2020, o GEI-ESPII tinha como função propor, acompanhar e articular medidas de enfrentamento. A SVSA/MS deixou de exercer a coordenação, assumindo apenas a secretaria executiva, e não houve previsão de participação de Estados e Municípios (Conass/Conasems). O regulamento também não fez referência expressa ao RSI.

Segundo o TCU (Acórdão nº 1.967/2023), o grupo não atuou na pandemia, pois suas funções foram absorvidas pelo Comitê de Crise da Casa Civil. O Tribunal recomendou que funções de Centro de Governo e COE sejam formalizadas em lei de modo permanente.

2.2 Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19

Criado pelo Decreto nº 10.277/2020 e ampliado pelo Decreto nº 10.404/2020, foi coordenado pela Casa Civil, assessorando diretamente o Presidente e definindo prioridades estratégicas. Reunia ministros de Estado, AGU, Banco Central, Anvisa e dirigentes de estatais (BB, Caixa, BNDES). O TCU (Acórdão nº 1.967/2023) constatou sobreposição de competências com o GEI-ESPII e ausência de clareza institucional. Foi extinto em 2022 (Decreto nº 11.077/2022), deixando em aberto a função de Centro de Governo.

2.3 Centro de Coordenação de Operações (no âmbito do Comitê de Crise)

Instituído pelo Decreto nº 10.289/2020, deveria coordenar operações do governo federal, articular ações públicas e privadas, monitorar iniciativas e repassar informações ao Presidente. Entretanto, não houve clareza normativa sobre sua diferenciação em relação ao GEI-ESPII e ao COE/MS. O MS não forneceu as informações necessárias para avaliação, fragilidade destacada pelo TCU.

2.4 Gabinete de Crise da Covid-19 do Ministério da Saúde

Criado pela Portaria GM/MS nº 3.190/2020, tinha como finalidade acompanhar cenários e subsidiar decisões no âmbito do MS. Coordenado pelo Ministro da Saúde, incluía representantes de secretarias do MS, além de Conass, Conasems e OPAS. Foram previstas reuniões semanais, com presença obrigatória do Ministro e dos representantes federativos. Contudo, o TCU (Acórdão nº 1.967/2023) verificou que, até outubro de 2020, sua estrutura não estava formalmente regulamentada, limitando sua efetividade.

2.5 Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid)

Instituída pelo Decreto nº 10.697/2021, a Secovid foi responsável por coordenar medidas nacionais, articular ações com estados e municípios, definir e coordenar a vacinação no PNI e dar transparência às ações. De caráter transitório, foi extinta em 2022.

2.6 Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19

Criado pelo Decreto nº 10.659/2021, foi coordenado pelo Presidente da República, com participação dos presidentes do Senado, da Câmara e de representante do Judiciário (como observador). Destinava-se a articular medidas interpoderes e interfederativas, mas teve atuação breve e limitada.

2.7 Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública (CTA-ESP)

Instituída pela Portaria GM/MS nº 440/2023, já no período pós-pandemia, é um órgão consultivo e científico, com composição plural de especialistas e instituições. É considerada

pelo MS um passo relevante para a consolidação de uma política nacional de resposta às emergências.

III – Problemas relevantes constatados durante a pandemia de Covid 19 sob a perspectiva da governança da resposta à Espin.

a) Rotatividade no Ministério da Saúde

O Acórdão TCU nº 1.967/2023 registrou que sucessivas trocas de ministros e dirigentes do MS provocaram retrabalhos, ineficiências e morosidade, prejudicando a execução de políticas durante a crise.

b) Falhas de liderança e governança

O CIG-MS, responsável por apoiar a alta administração, mostrou-se inoperante. O Acórdão TCU nº 2.463/2022 – Plenário registrou ausência de Planejamento Estratégico Institucional e baixa efetividade do comitê. Embora tenham ocorrido reuniões em 2022 e 2023, não houve continuidade. O TCU reforça que a governança exige engajamento da alta gestão.

c) Coordenação insuficiente do MS

O COE-nCoV não exerceu plenamente sua função de articulação, inclusive na aquisição de insumos e testagem, segundo o TCU (Acórdão nº 1.967/2023). Outro levantamento (Acórdão nº 2.306/2021) mostrou ausência de protagonismo do MS na coordenação de hospitais de campanha. O Conasems atribuiu falhas a disputas políticas e falta de alinhamento federativo. O CNS destacou que o MS não cumpriu seu papel de coordenação do SUS.

d) Exercício prejudicial da liderança

Notas do Conasems (2020) criticaram discursos de alta liderança que deslegitimavam medidas sanitárias. O TCU (Acórdão nº 1.967/2023) destacou que autoridades minimizaram a doença, vacinas e medidas de proteção. O CNS qualificou a postura como política que comprometeu a resposta nacional.

e) Atuação descoordenada dos entes federativos

O relatório da Fiocruz/CEPEDES constatou que, diante da falta de confiança no governo federal, estados e DF adotaram medidas isoladas e heterogêneas, com baixa coordenação nacional, ausência de COE em muitos estados, falhas em testagem e dificuldades de cooperação federativa.

f) Subnotificação e ausência de política nacional de testagem

O Acórdão TCU nº 2.817/2020 determinou que o MS elaborasse uma política de testagem. A ausência de diretrizes nacionais prejudicou monitoramento adequado, dificultou comportamento consciente da população e enfraqueceu o planejamento sanitário.

g) Centralização decisória e baixa participação

Instâncias criadas (GEI-ESPII e Comitê de Crise) limitaram a participação de entes subnacionais e especialistas. O Acórdão TCU nº 1.616/2020 destacou a ausência de assentos permanentes para representantes da saúde. O STF (ADIs sobre MP nº 926/2020) reforçou que competências devem ser compartilhadas com base em evidências científicas e nas diretrizes da OMS.

h) Plano de Contingência sem critérios claros

Segundo o TCU (Acórdão nº 335/2022 – Plenário), o Plano de Contingência não estabelecia critérios objetivos para quarentena, previstos na Lei nº 13.979/2020, levando a critérios próprios dos estados, gerando insegurança e baixa adesão. O STF (ADPF nº 672) reconheceu autonomia de estados e municípios, mas o TCU reforçou que cabia à União editar normas gerais.

i) Resultados inefetivos: excesso de mortalidade

Estudos da OPAS (2022) e da OMS (2022, 2023) apontaram excesso de 14,9 milhões de mortes no mundo em 2020-2021, com o Brasil entre os países mais afetados (657.426 óbitos em excesso, taxa de 308/100 mil hab., acima da média mundial de 190). O Conass (2021) destacou excesso de 24% em 2020 e 46% em 2021. O TCU, por meio do Acórdão nº 1.967/2023 – Plenário, apontou o Brasil entre os países com maiores taxas.

IV - Aspectos que demandam ação coordenada durante uma Espin – Resultados na pandemia de Covid 19.

a) Protocolos de testagem e notificação

A Lei nº 6.259/1975 e a Resolução nº 588/2018 estabelecem a notificação compulsória e a importância das ações laboratoriais coordenadas pelo SISLAB/MS. A OMS recomenda testagem imediata em casos suspeitos. O TCU (Acórdão nº 2.817/2020) recomendou uma política nacional de testagem, diante da ausência de estratégia clara. O MS instituiu o programa Diagnosticar para Cuidar e, depois, o PNE-Teste (Portaria nº 1.046/2021), incluindo TR-AG em larga escala e integração à RNDS. O Conasems apontou atrasos pela centralização dos testes, o que prolongou transmissões. O TCU (Acórdãos nº 1.873/2021 e nº 2.878/2021) concluiu que o programa foi limitado e tardio.

b) Hospitais de campanha e leitos

Nos picos da pandemia, o sistema sofreu alta mortalidade e colapso parcial. O MS publicou orientações em 2020, mas, segundo a Abrasco (2022), a responsabilidade foi deixada aos estados e municípios, de forma fragmentada e sem coordenação nacional. O TCU (Acórdão nº 2.306/2021) constatou a ausência de liderança do MS até meados de 2020. Somente depois o órgão editou recomendações, restringindo hospitais de campanha a última opção. Houve expansão de UTIs, porém sem articulação com a APS ou monitoramento nacional.

c) Política de vacinação

A Lei nº 6.259/1975 atribui ao MS a coordenação do PNI. Durante a pandemia, a execução coube à Secretaria Executiva e, depois, à SECOVID, com o PNO publicado em 12/2020. A vacinação começou em 01/2021. O TCU (Acórdão nº 2.878/2021) recomendou pactuação tripartite e transparência nos critérios de distribuição. A Abrasco destacou que a falta de liderança federal gerou estratégias heterogêneas, centralização de postos e baixa articulação com a APS, prejudicando a busca ativa.

d) Controle migratório e viajantes

A Lei nº 13.979/2020 e a Portaria CC/PR nº 126/2020 restringiram entradas no país. O TCU (Acórdãos nº 2.878/2021 e nº 335/2022) cobrou articulação entre MS, Anvisa e secretarias locais para definir quarentena, fiscalização e rastreamento. Em 2022, a Portaria Interministerial nº 670 passou a exigir vacinação completa, admitindo exceções com teste negativo.

e) Medidas não farmacológicas

A Lei nº 14.019/2020 regulamentou máscaras somente em julho de 2020, quando já adotadas pelos estados. A Portaria GM/MS nº 1.565/2020 previu distanciamento, etiqueta respiratória, higienização e isolamento domiciliar, delegando a decisão final às autoridades locais. O STF (ADI 6586/2020) reafirmou a possibilidade de vacinação compulsória indireta e a competência concorrente entre União, estados e municípios.

f) Oxigênio medicinal

A gestão foi atribuída a estados e municípios, cabendo apoio da União. O Plano Oxigênio Brasil deu suporte a entes em crise (como Amazonas). Contudo, o TCU (Acórdão nº 676/2022) determinou que o MS elaborasse plano nacional para monitorar o abastecimento.

g) Aquisição de medicamentos

O TCU, por meio dos Acórdãos nº 2.306/2021 e nº 2.878/2021 – Plenário, apontou morosidade e falhas na aquisição centralizada pelo MS, comprometendo a assistência hospitalar e prejudicando princípios da eficiência.

V – Referências

ABRASCO. Dossiê ABRASCO: Pandemia de COVID-19 / Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Rio de Janeiro: Abrasco, 2022. 314p. Disponível em: https://abrasco.org.br/download/dossie-abrasco-pandemia-de-covid-19/

BRASIL, 2009. ANVISA. Regulamento Sanitário Internacional / RSI – 2005, 2009. 79p. ISBN 978-92-4-151618-1.

Brasil, 2014a. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 44 p. : il.

BRASIL, 2014b. Tribunal de Contas da União. Referencial para avaliação de governança em políticas públicas / Tribunal de Contas da União. – Brasília : TCU, 2014. 91 p.

Brasil, 2016. Tribunal de Contas da União. Referencial para avaliação da governança do Centro de Governo / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin), 2016. 95 p.

Brasil, 2020b. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU / Tribunal de Contas da União. Edição 3 - Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado – SecexAdministração, 2020. 242p.

BRASIL, 2020c. Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADI 6341 MC- Ref / DF - Distrito Federal. Disponível em: < https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;adi:2020-04-15;6341-5881265 >. Consulta em: 22/02/2024.

BRASIL, 2022. Ministério da Saúde declara fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Covid-19. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/ministerio-da-saude-declara-fim-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-nacional-pela-covid-19>. Consulta em: 25/03/2024.

BRASIL, 2022b. Controladoria-Geral da União. Referencial de Auditoria Interna: Referencial de Sustentabilidade do SUS, 2022. 118p.

BRASIL, 2024. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil (Painel). Disponível em: <https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>. Consulta em: 25/03/2024.

BRITISH MEDICAL JOURNAL (BMJ), 2023. Full list of authors and-signatories to climate emergency editorial October 2023. <https://www.bmj.com/content/full-list-authors-and-signatories-climate-nature-emergency-editorial-october-2023>. Consulta em: 18/12/2023.

CEPEDES / ENSP/ FIOCRUZ, 2020. A gestão de riscos e governança na pandemia por covid-19 no Brasil, análise dos decretos estaduais no primeiro mês, relatório técnico e sumário executivo, 2020. 78p. Disponível em: < https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41452>. Consulta em: 21/02/2024.CEPEDISA/FSP/USP, 2021. A linha do tempo da estratégia federal

de disseminação da covid-19. 2021, 200p. Disponível em: <https://cepedisa.fsp.usp.br/wp-content/uploads/2024/01/CEPEDISA-USP-Linha-do-Tempo-Maio-2021_rev4-1.pdf>. Consulta em: 04/03/2024.

CONASEMS, 2020. Nota. Posicionamento sobre a pandemia de covid-19 e medidas de isolamento social. Disponível em: <https://www.cosemssc.org.br/conasems-posicionamento-sobre-a-pandemia-de-covid-19-e-medidas-de-isolamento-social/>. Consulta em: 21/02/2024.

CONASS, 2021. O Conceito de "Excesso de Mortalidade": Brasil e COVID-19. Disponível em: <https://www.conass.org.br/o-conceito-de-excesso-de-mortalidade-brasil-e-covid-19/>. Consulta em: 15/12/2023.

FARENA, D.V.M. Direito à saúde, princípio da precaução e a pandemia de Covid-19. In: Direitos fundamentais em processo: estudos em comemoração aos 20 anos da Escola Superior do Ministério Público da União / organizadores: Paulo Gustavo Gonet Branco, Manoel Jorge e Silva Neto, Helena Mercês Claret da Mota, Cristina Rasia Montenegro, Carlos Vinícius Alves Ribeiro. -- Brasília: ESMPU, 2020. 848 p.

INSTITUTO RUI BARBOSA, 2020. Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público. NBASP 9020 – AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Disponível em: <https://nbasp.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2022/11/NBASP-9020-Avaliacao-de-Politicas-Publicas.pdf >. Consulta em: 25.03.2024.

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (JAMA), 2023. Time to Treat the Climate and Nature Crisis as One Indivisible Global Health Emergency. Editorial. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2811168>. Consulta em: 18.12.2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS), 2022. Excesso de mortalidade associado à pandemia de COVID-19 foi de 14,9 milhões em 2020 e 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/5-5-2022-excesso-mortalidade-associado-pandemia-covid-19-foi-149-milhoes-em-2020-e-2021>. Consulta em: 27.10.2023.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 2009. What is Good Governance? Thailand, 2009. Disponível em: < https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>. Consulta em: 01.03.2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2019. Health Emergency and Disaster Risk Management Framework, 2019. 48p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2023. Global excess deaths associated with COVID-19 (modelled estimates). Disponível em: <https://www.who.int/data/sets/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-modelled-estimates>. Consulta em: 27.10.2023